Carta Acordo SCON2026-00087

Programa de Aprimoramento em Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura

Segurança do Paciente

Indicadores, cultura de segurança e eventos adversos

Luis Antonio Diego, TSA-SBA

Sociedade Brasileira de Anestesiologia
Instituto SBA de Simulação e Certificação
OPAS
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Programa de Aprimoramento em Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE

Declaro não apresentar conflito de interesse

De acordo com:

- Código de Ética Médica (27 de setembro de 2018).
- Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
- RDC 96/2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- Resolução 1.595/ 2000 do Conselho Federal de Medicina.

SBA Sociedade Brasileira de Anestesiologia
Instituto SBA de Simulação e Certificação
OPAS Organização Pan-Americana da Saúde / Organización Mundial de la Salud
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Programa de Aprimoramento em Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura

Objetivo:

Geral: ao final, o participante deverá ser capaz de relacionar indicadores, cultura de segurança e análise de eventos adversos como partes de um mesmo ciclo de aprendizagem e melhoria, e de aplicá-lo à própria prática anestésica

QUALIDADE E SEGURANÇA EM ANESTESIOLOGIA

Roteiro

MÓDULO 1

Segurança & Taxonomia

- Segurança como dimensão da qualidade
- Taxonomia OMS • Diferenciação Erro de Violação
- EA,Incidente, Near Miss e Dano

MÓDULO 2

Indicadores em Anestesia

- Tríade de Donabedian

Gestão guiada por dados

- Indicadores de Estrutura e Processo

MÓDULO 3

Cultura de Segurança

- 5 estágios da maturidade da CS
- Cultura Justa
- Evolução: Segurança I Segurança II

MÓDULO 4

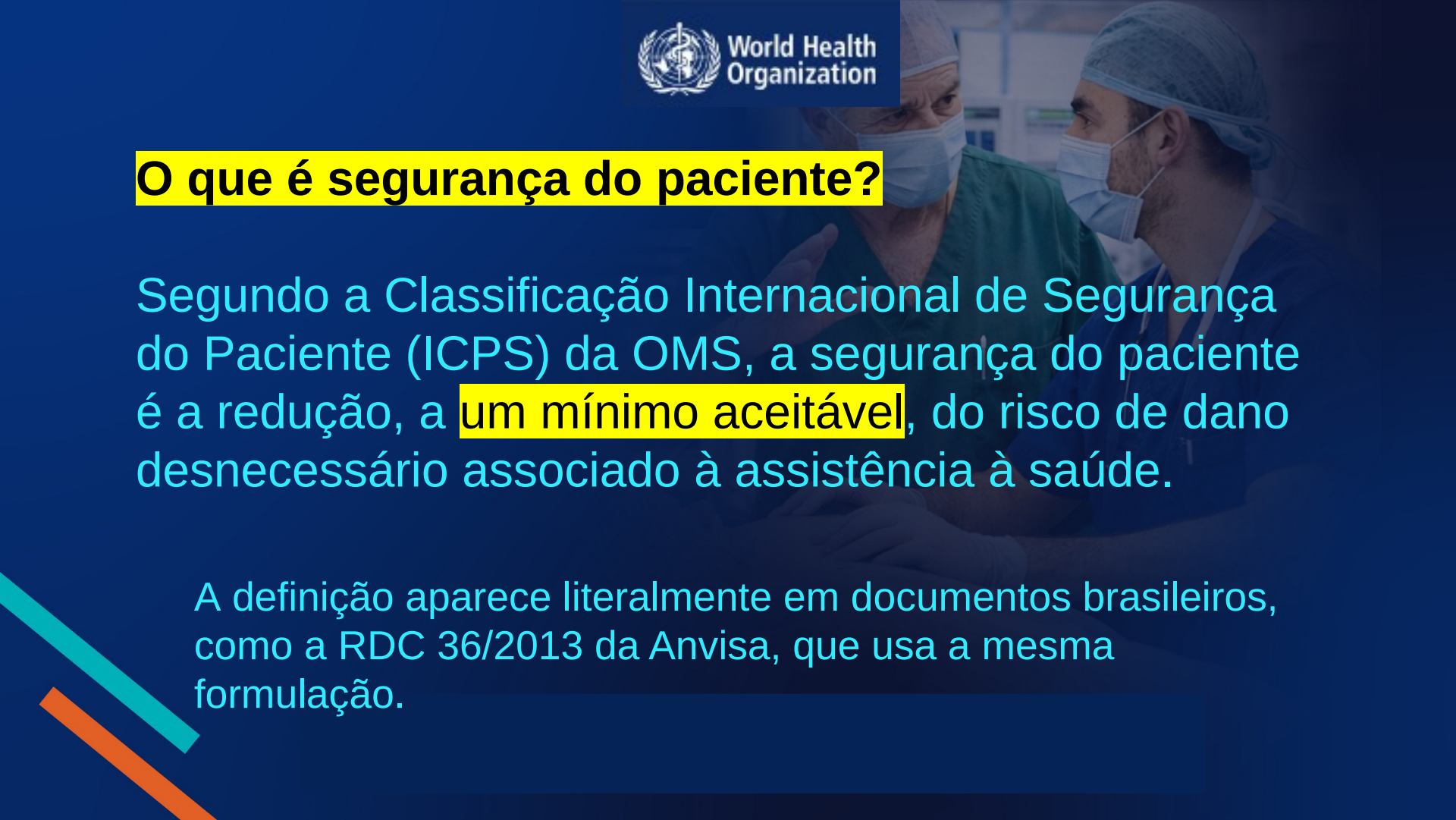
Síntese & Debates

- Qualidade e Segurança
- Fenômeno da Segunda Vítima
- Prática de Disclosure ao paciente

MÓDULO 1

Segurança & Taxonomia

- Segurança como dimensão da qualidade
- Taxonomia OMS
- Diferenciação entre Erro e Violação
- Evento Adverso, Incidente, Near Miss e Dano

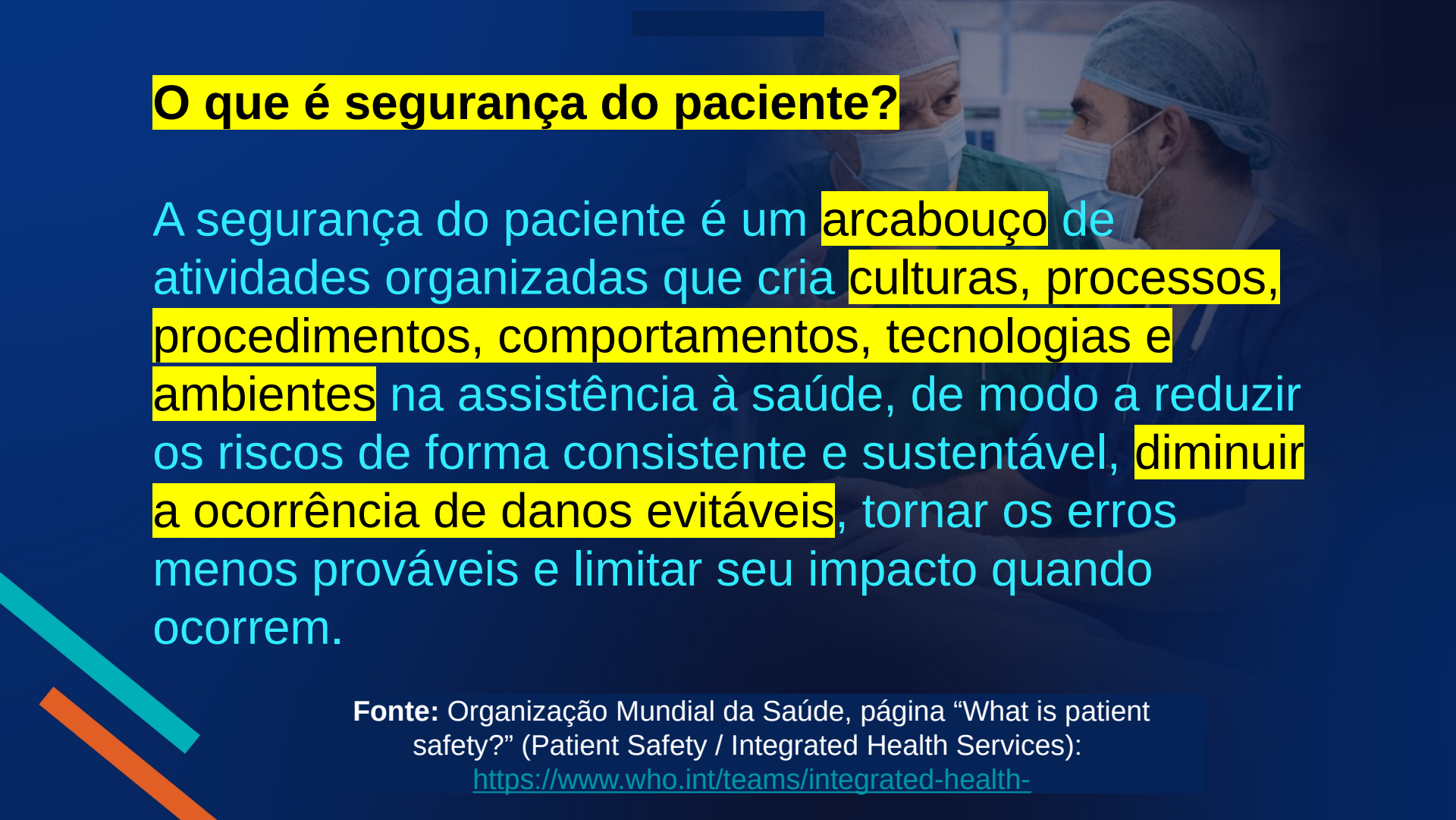


World Health Organization

O que é segurança do paciente?

Segundo a Classificação Internacional de Segurança do Paciente (ICPS) da OMS, a segurança do paciente é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à assistência à saúde.

A definição aparece literalmente em documentos brasileiros, como a RDC 36/2013 da Anvisa, que usa a mesma formulação.



O que é segurança do paciente?

A segurança do paciente é um arcabouço de atividades organizadas que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes na assistência à saúde, de modo a reduzir os riscos de forma consistente e sustentável, diminuir a ocorrência de danos evitáveis, tornar os erros menos prováveis e limitar seu impacto quando ocorrem.

Fonte: Organização Mundial da Saúde, página “What is patient safety?” (Patient Safety / Integrated Health Services): https://www.who.int/teams/integrated-health-

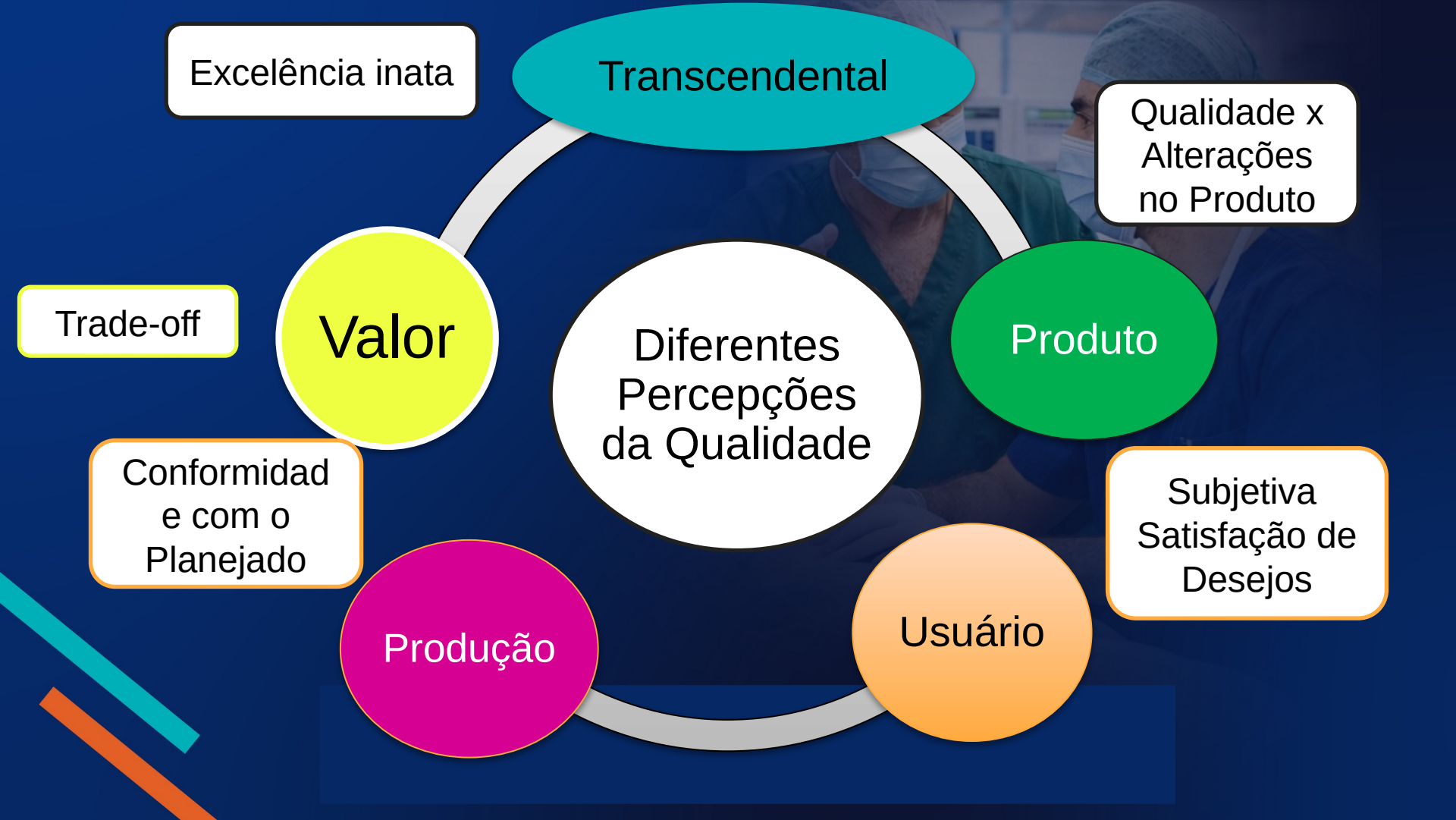
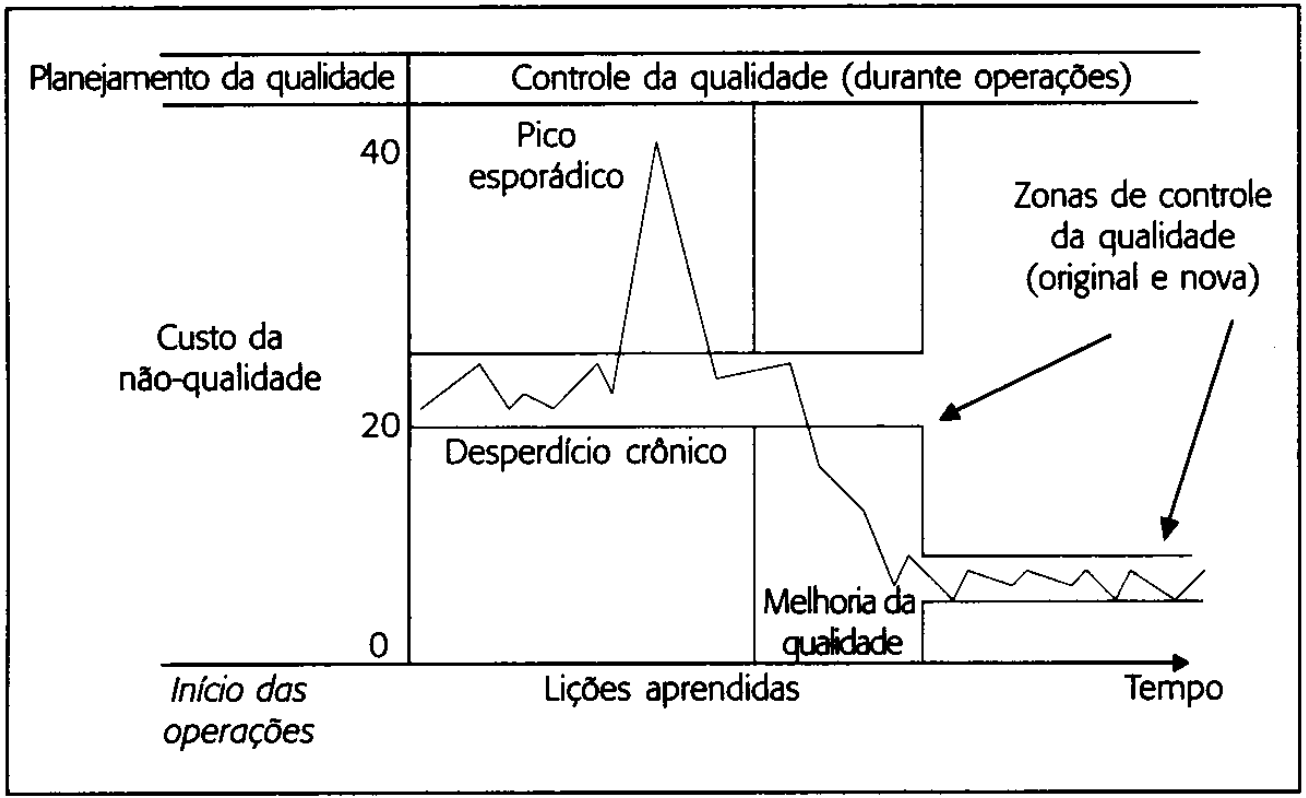
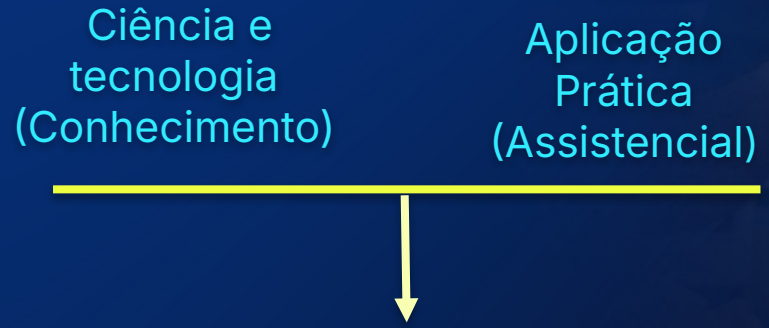

Excelência inata
Transcendental
Qualidade x Alterações no Produto
Trade-off
Valor
Diferentes Percepções da Qualidade
Produto
Conformidade com o Planejado
Subjetiva Satisfação de Desejos
Produção
Usuário

Diagrama da trilogia Juran



Componentes da Qualidade (Donabedian – 1980))

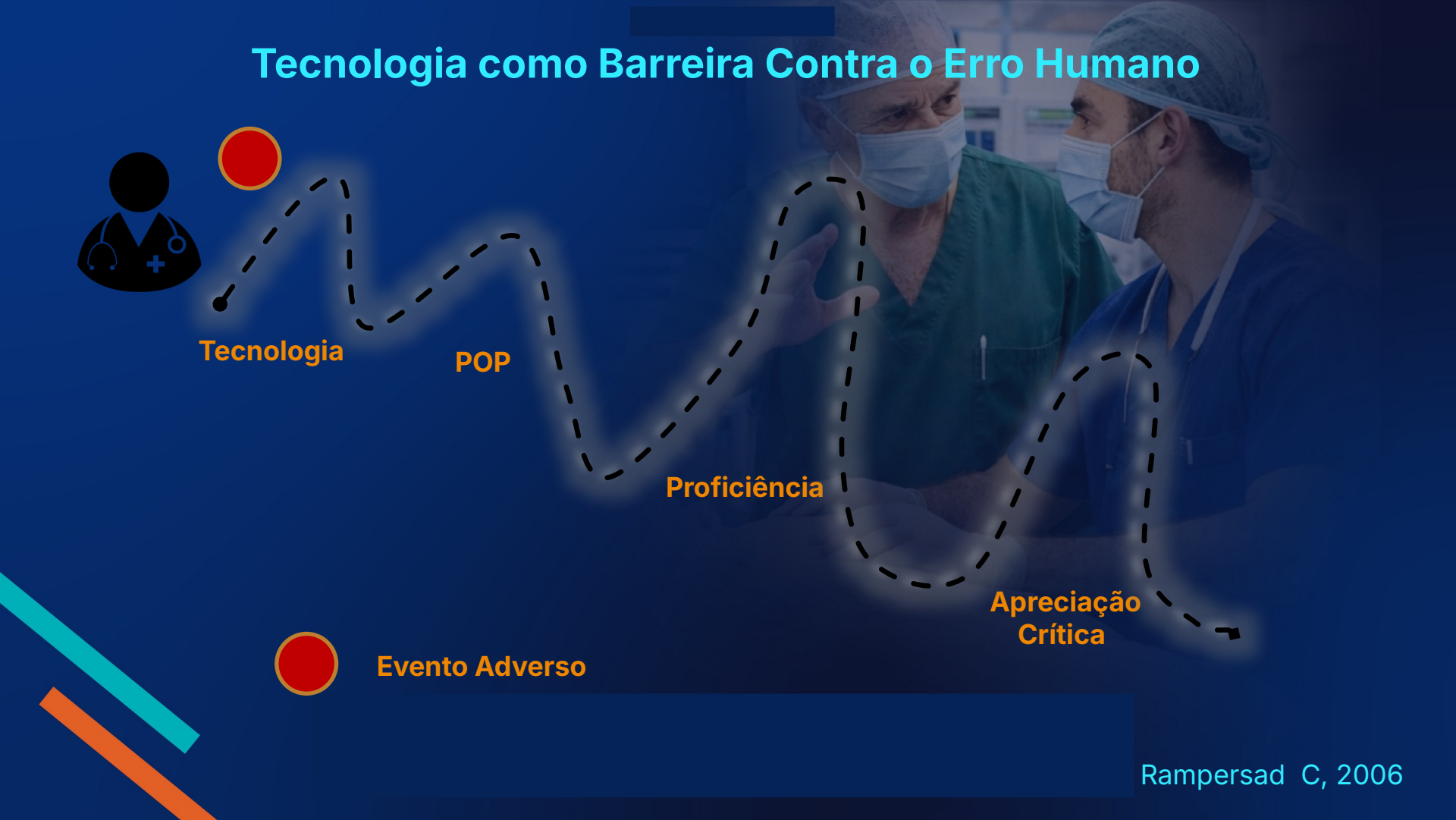


Dimensões da Qualidade

- Efetividade
- Eficiência
- Acesso
- Aceitabilidade
- Continuidade
- Adequação
- Respeito aos direitos das pessoas
- Segurança do paciente

EQUIDADE

Tecnologia como Barreira Contra o Erro Humano



Rampersad C, 2006

Componentes da Qualidade (Institute of Medicine - 2001)

Dimensões da Qualidade

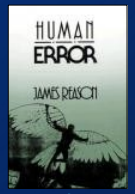
- Segurança do paciente
- Efetividade
- Cuidado centrado no paciente
- Oportunidade
- Eficiência
- Equidade



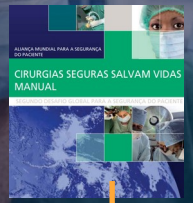
Segurança como dimensão da qualidade



Avedis Donabedian











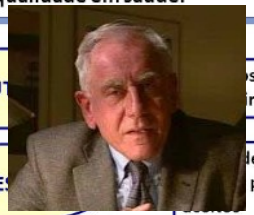
HMPS
Harvard

1961 — 1985 — 1990 — 1994 — 1999 — 2002 — 2004 — 2005 — 2008 — 2017

Leape
Error in Medicine
JAMA



avaliação da qualidade em saúde.





ESTRUT

PROCES

des envolvendo profissionais de
pacientes com base em padrões

RESULTADO

Produto final da assistência prestada ao paciente

James Reason

1º Desafio Global

Clean Care is Safer Care: The First Global Challenge of the WHO World Alliance for Patient Safety

Didier Pittet, MD, MS; Sir Liam Donaldson, MD, MSc

Dr. Pittet is from the Global Patient Safety Challenge, WHO World Alliance for Patient Safety; and Dr. Donaldson is from the WHO World Alliance for Patient Safety, WHO Headquarters, Geneva, Switzerland.

Patient safety is a critical component of improving the quality of health care worldwide. Confronted with this important issue, the 55th World Health Assembly in 2002 adopted a resolution urging countries to pay the closest possible attention to the problem of patient safety and strengthen safety and monitoring systems. The resolution urged the World Health Organization (WHO) to lead the process of establishing global norms and standards and supporting country efforts in developing patient safety policies and practices.

In May 2004, the 57th Assembly supported the cre-

people worldwide, complicates the delivery of patient care, contributes to patient deaths and disability, promotes resistance to antibiotics, and generates additional expenditure to that already incurred by the patients' underlying disease.

Indeed, health care–associated infection is a growing international problem. Patients are becoming more susceptible to infections because of more serious underlying illnesses. Poor compliance with hand hygiene by health care staff, increased recourse to invasive medical devices, and care of the critically ill as well as lack of access to safe

Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (primeira edição)

Antes da indução anestésica ▸▸▸▸▸▸▸▸▸ Antes da incisão cirúrgica ▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸ Antes de o paciente sair da sala de operações

IDENTIFICAÇÃO

- ☐ PACIENTE CONFIRMOU
  - IDENTIDADE
  - SÍTIO CIRÚRGICO
  - PROCEDIMENTO
  - CONSENTIMENTO
- ☐ SÍTIO DEMARCADO/NÃO SE APLICA
- ☐ VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ANESTÉSICA CONCLUÍDA
- ☐ OXÍMETRO DE PULSO NO PACIENTE E EM FUNCIONAMENTO

O PACIENTE POSSUI:

ALERGIA CONHECIDA?
- ☐ NÃO
- ☐ SIM

VIA AÉREA DIFÍCIL/RISCO DE ASPIRAÇÃO?
- ☐ NÃO
- ☐ SIM, E EQUIPAMENTO/ASSISTÊNCIA DISPONÍVEIS

RISCO DE PERDA SANGUÍNEA > 500 ML (7 ML/KG EM CRIANÇAS)?
- ☐ NÃO
- ☐ SIM, E ACESSO ENDOVENOSO ADEQUADO E PLANEJAMENTO PARA FLUIDOS

CONFIRMAÇÃO

- ☐ CONFIRMAR QUE TODOS OS MEMBROS DA EQUIPE SE APRESENTARAM PELO NOME E FUNÇÃO
- ☐ CIRURGIÃO, ANESTESIOLOGISTA E A EQUIPE DE ENFERMAGEM CONFIRMAM VERBALMENTE:
  - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
  - SÍTIO CIRÚRGICO
  - PROCEDIMENTO

EVENTOS CRÍTICOS PREVISTOS
- ☐ REVISÃO DO CIRURGIÃO: QUAIS SÃO AS ETAPAS CRÍTICAS OU INESPERADAS, DURAÇÃO DA OPERAÇÃO, PERDA SANGUÍNEA PREVISTA?
- ☐ REVISÃO DA EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA: HÁ ALGUMA PREOCUPAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO PACIENTE?
- ☐ REVISÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: OS MATERIAIS NECESSÁRIOS (EX. INSTRUMENTAIS, PRÓTESES) ESTÃO PRESENTES E DENTRO DO PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO? (INCLUINDO RESULTADOS DO INDICADOR)? HÁ QUESTÕES RELACIONADAS A EQUIPAMENTOS OU QUAISQUER PREOCUPAÇÕES?

A PROFILAXIA ANTIMICROBIANA FOI REALIZADA NOS ÚLTIMOS 60 MINUTOS?
- ☐ SIM
- ☐ NÃO SE APLICA

AS IMAGENS ESSENCIAIS ESTÃO DISPONÍVEIS?
- ☐ SIM
- ☐ NÃO SE APLICA

REGISTRO

O PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM OU DA EQUIPE MÉDICA CONFIRMA VERBALMENTE COM A EQUIPE:

- ☐ REGISTRO COMPLETO DO PROCEDIMENTO INTRA-OPERATÓRIO, INCLUINDO PROCEDIMENTO EXECUTADO
- ☐ SE AS CONTAGENS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COMPRESSAS E AGULHAS ESTÃO CORRETAS (OU NÃO SE APLICAM)
- ☐ COMO A AMOSTRA PARA ANATOMIA PATOLÓGICA ESTÁ IDENTIFICADA (INCLUINDO O NOME DO PACIENTE)
- ☐ SE HÁ ALGUM PROBLEMA COM EQUIPAMENTO PARA SER RESOLVIDO

- ☐ O CIRURGIÃO, O ANESTESIOLOGISTA E A EQUIPE DE ENFERMAGEM REVISAM PREOCUPAÇÕES ESSENCIAIS PARA A RECUPERAÇÃO E O MANEJO DO PACIENTE (ESPECIFICAR CRITÉRIOS MÍNIMOS A SEREM OBSERVADOS. EX: DOR)

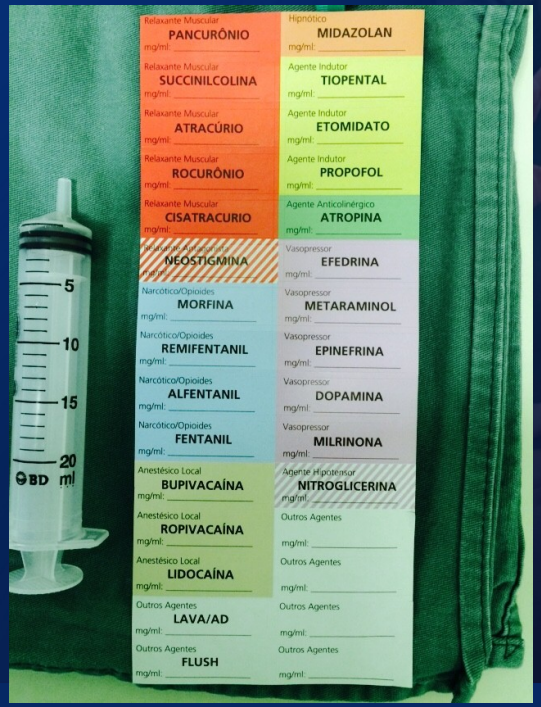
Assinatura

2º Desafio Global

Segurança no uso de medicações



3º Desafio Global

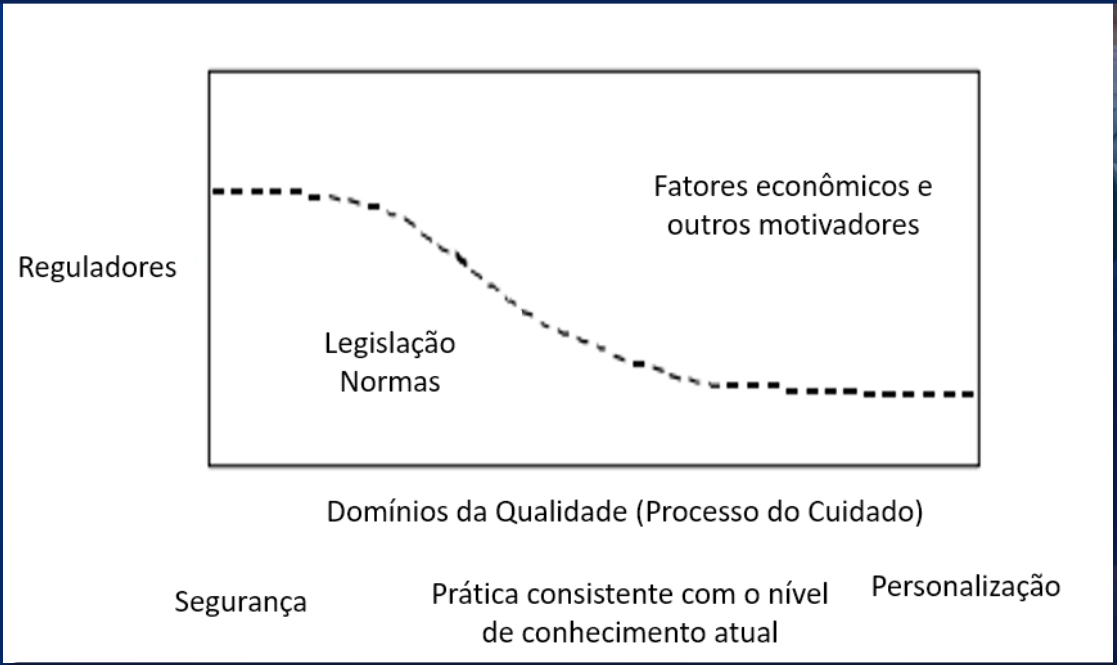


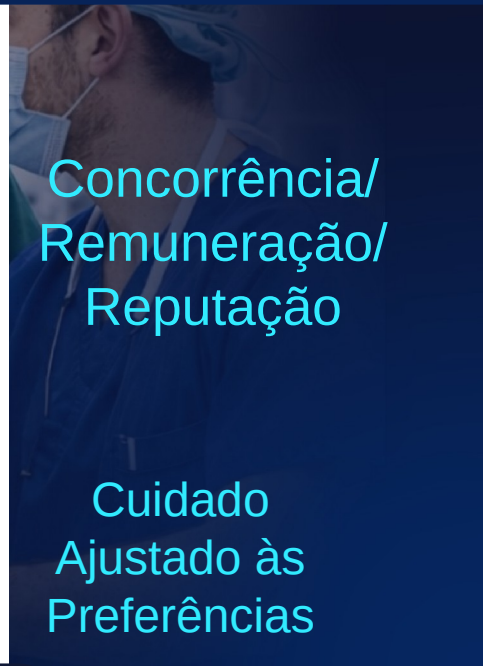


Forças de Equilíbrio na Segurança do Paciente

Notificação
ANVISA
Resoluções
do CFM
Estatuto do
Paciente

Protocolos
Checklists





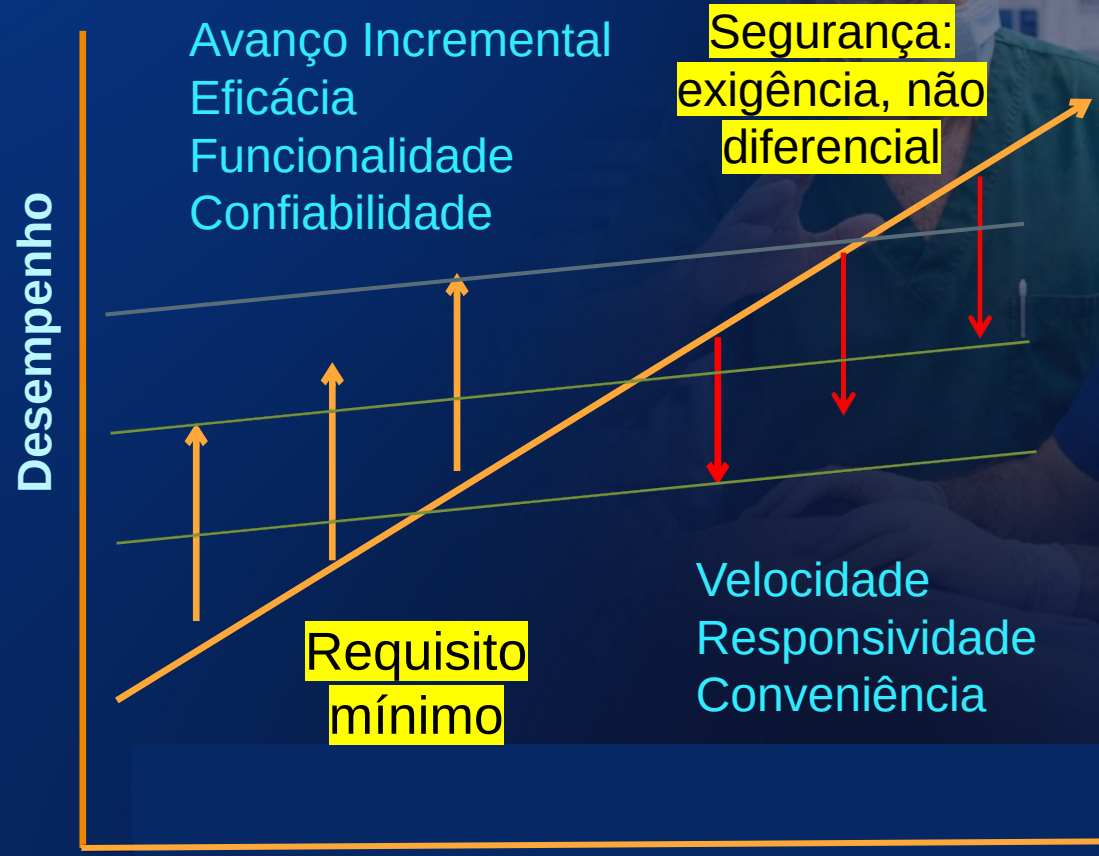
Concorrência/
Remuneração/
Reputação

Cuidado
Ajustado às
Preferências

Formação Profissional
Cultura / Pares

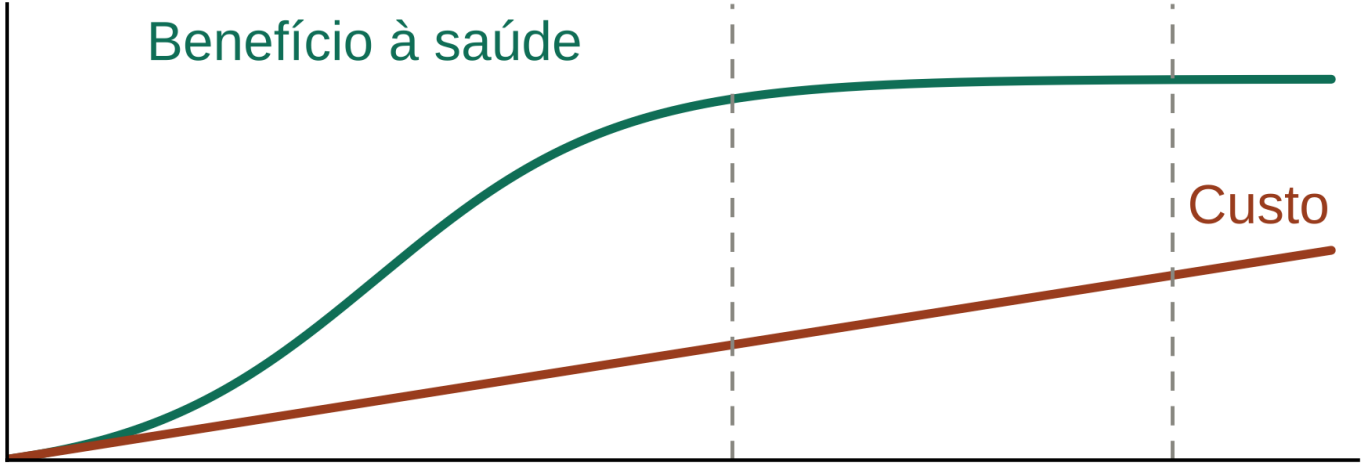
To Err Is Human: Building a Safer Health System, 1999 – IOM

Bases de competição por camada de mercado

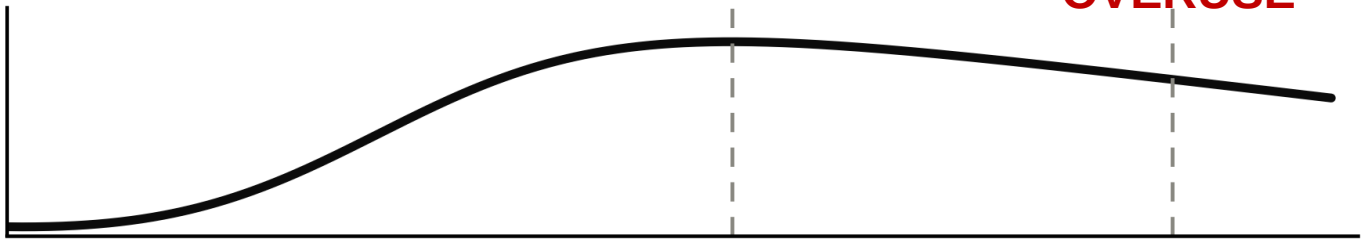


C.Christensen, 2009

Benefício e custo



Benefício menos custo



A: ótimo

B: excesso

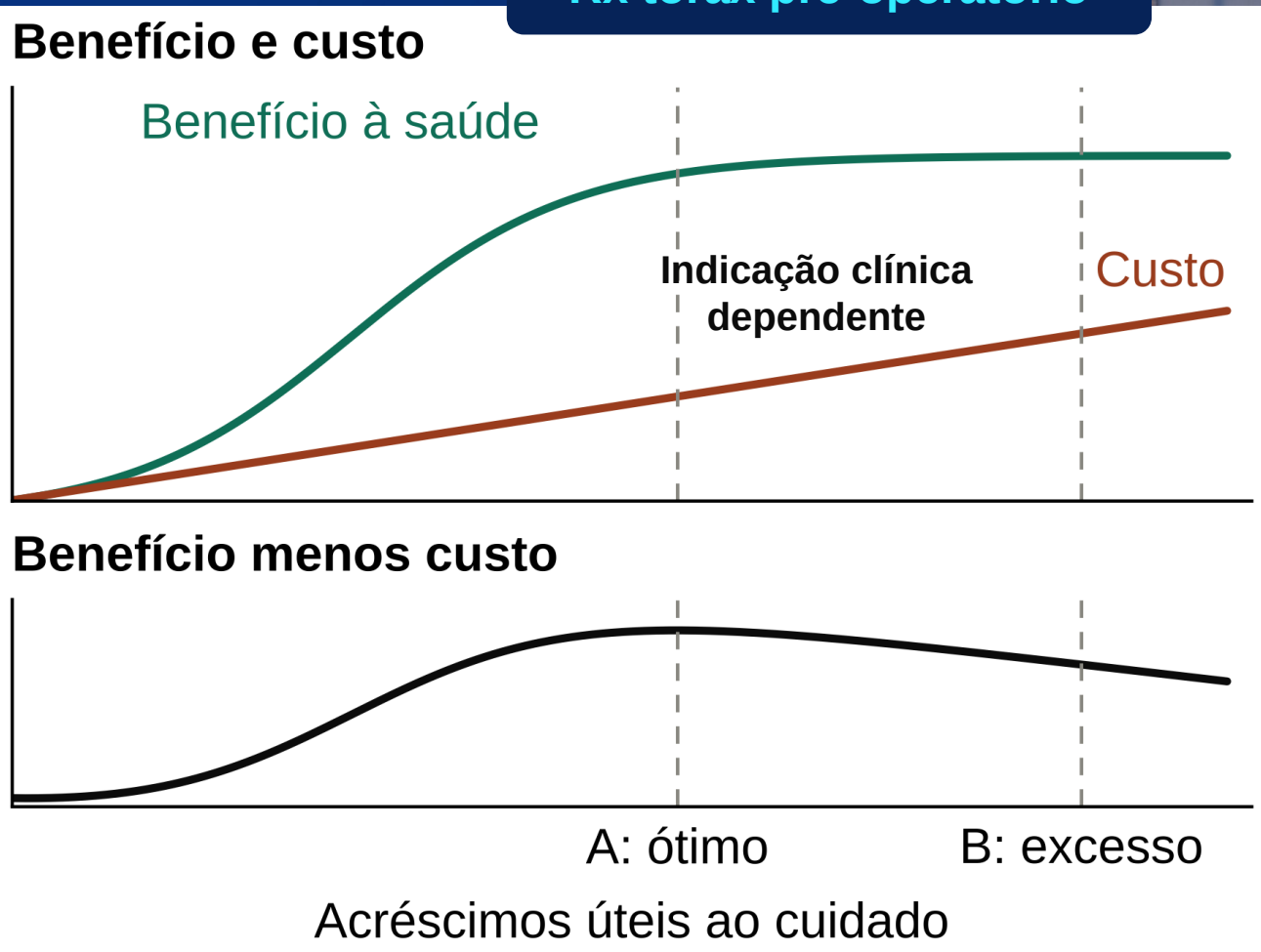
Acréscimos úteis ao cuidado

Mais cuidado nem sempre é melhor

O cuidado deve ser ponderado pelo risco e pelos resultados esperados

Adaptado:
A.Donabedian

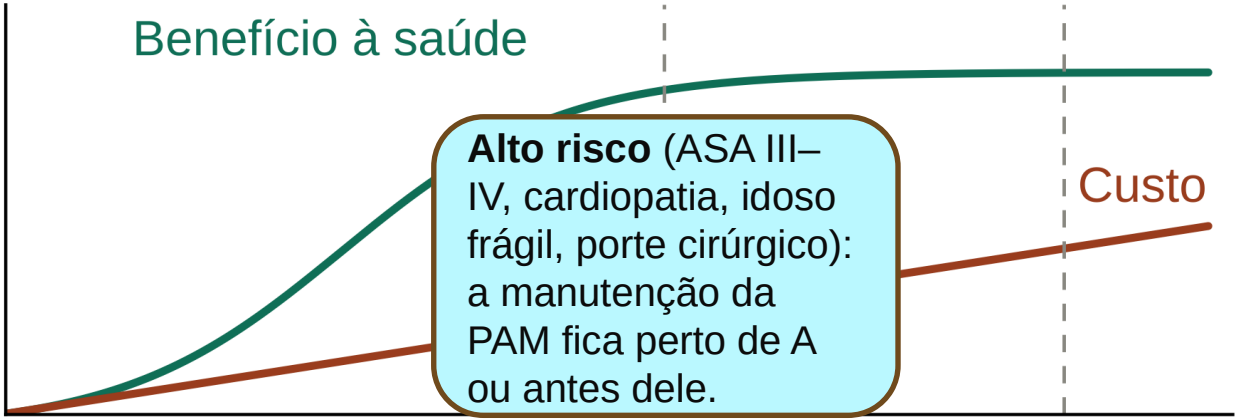
Rx tórax pré-operatório



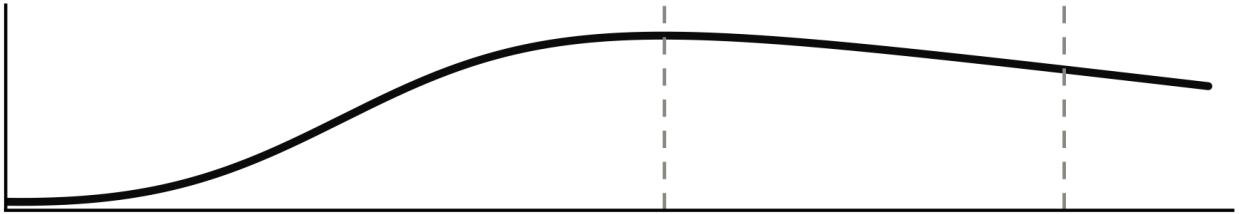
Paciente de baixo risco.
Após o ótimo A por não acrescentar ganho

Monitorização da Pressão Arterial Invasiva

Benefício e custo



Benefício menos custo



A: ótimo B: excesso

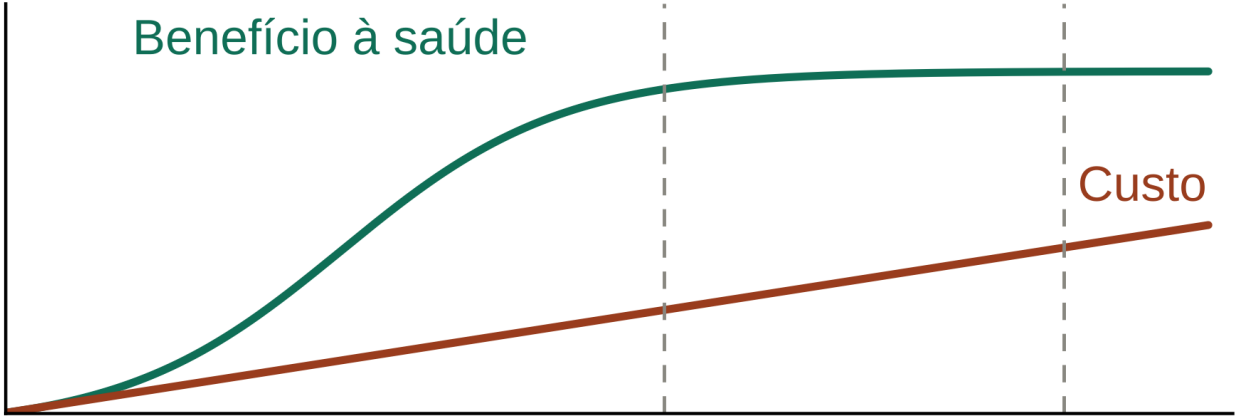
Acréscimos úteis ao cuidado

O ótimo se desloca com o risco do paciente e o porte da cirurgia.

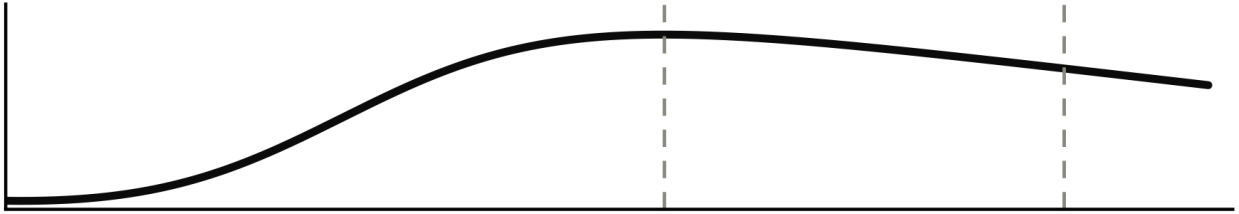
Baixo risco, cirurgia de pequeno porte: cânula arterial tende a ficar após o ótimo A.

Monitorização com Cateter da Artéria Pulmonar

Benefício e custo



Benefício menos custo



A: ótimo B: excesso

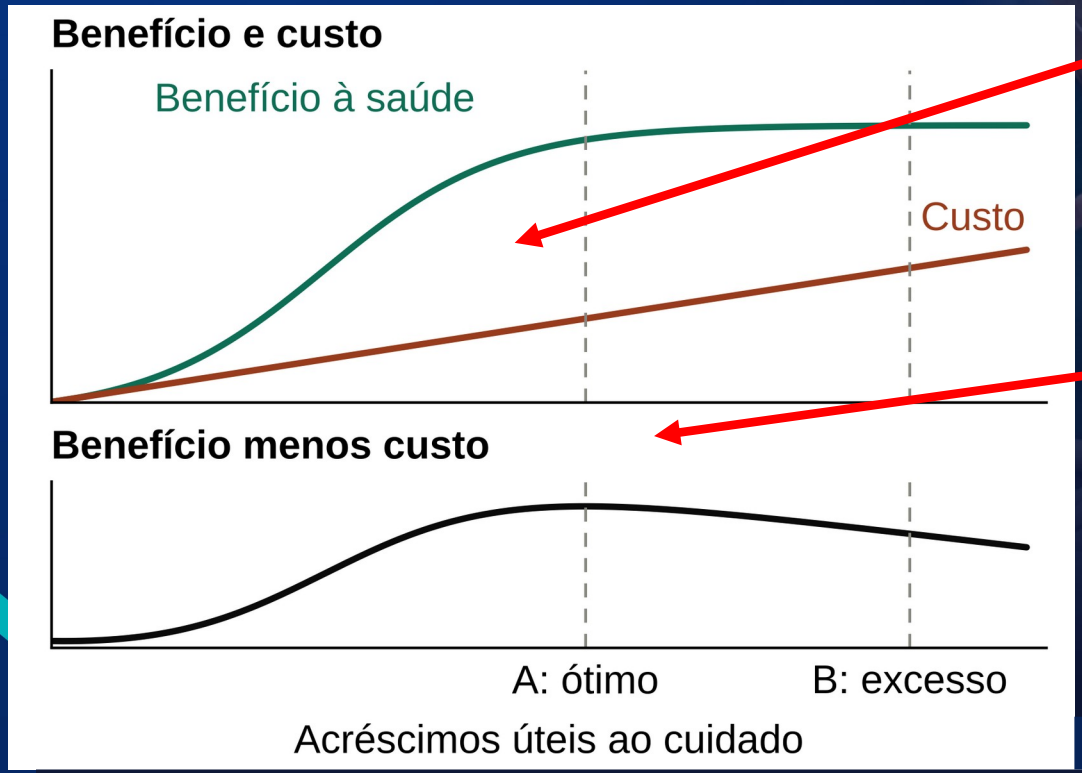
Acréscimos úteis ao cuidado

Alto risco

Benefícios não é consistente

Baixo risco: sem benefícios e podendo comprometer a Segurança

BIS: onde o benefício compensa o custo?



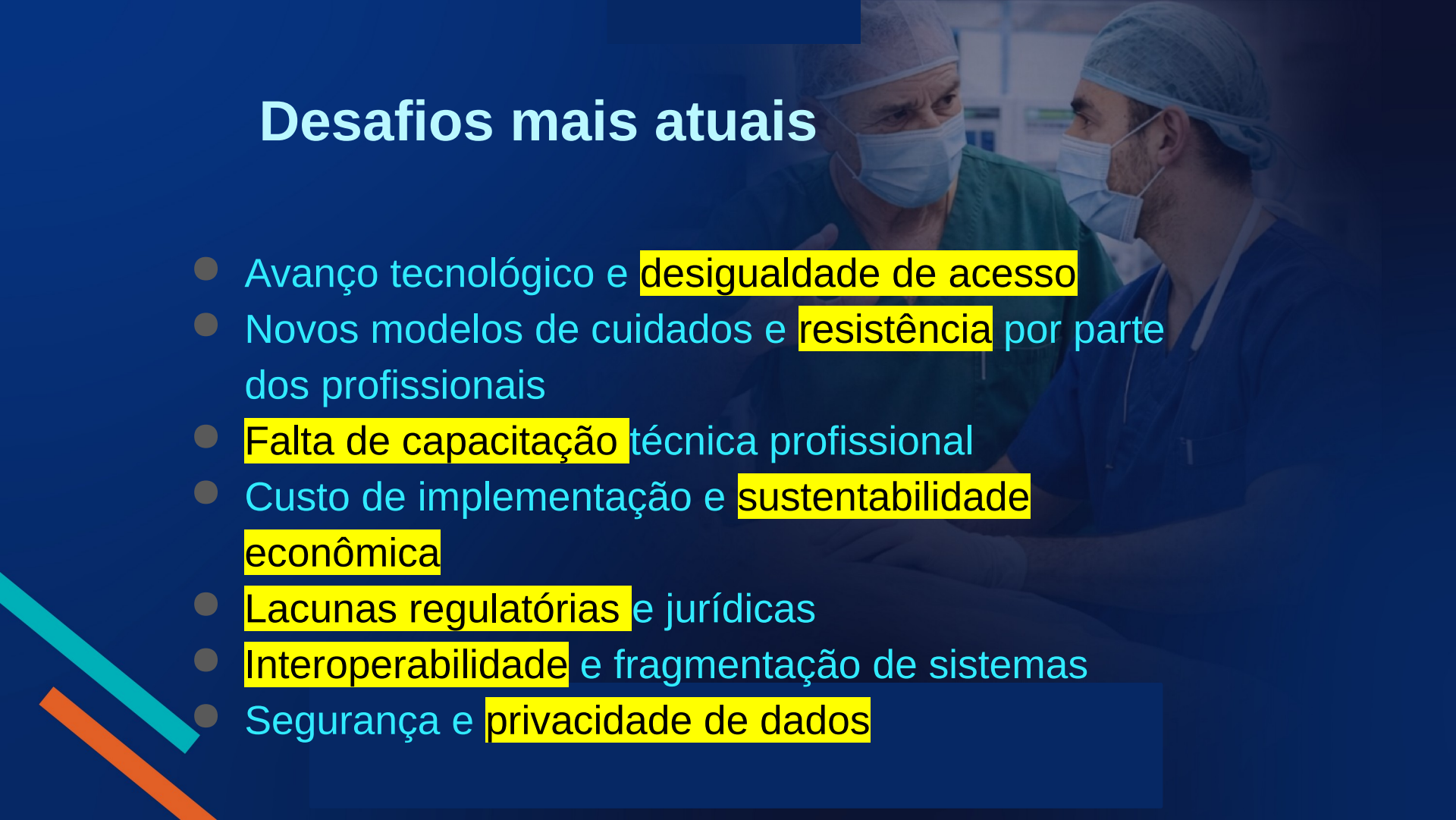
Antes de A: alto risco de consciência, vs prática habitual

Perto de A: vs gás expirado monitorizado, o BIS não foi superior

Após A: sem benefício demonstrado para delirium

Fontes: Myles 2004; Avidan 2008 e 2011; Wildes 2019; Short 2019; Lewis 2019 (Cochrane).

Desafios mais atuais



- Avanço tecnológico e desigualdade de acesso
- Novos modelos de cuidados e resistência por parte dos profissionais
- Falta de capacitação técnica profissional
- Custo de implementação e sustentabilidade econômica
- Lacunas regulatórias e jurídicas
- Interoperabilidade e fragmentação de sistemas
- Segurança e privacidade de dados

Plano Global OMS 2021-2030

Visão da OMS



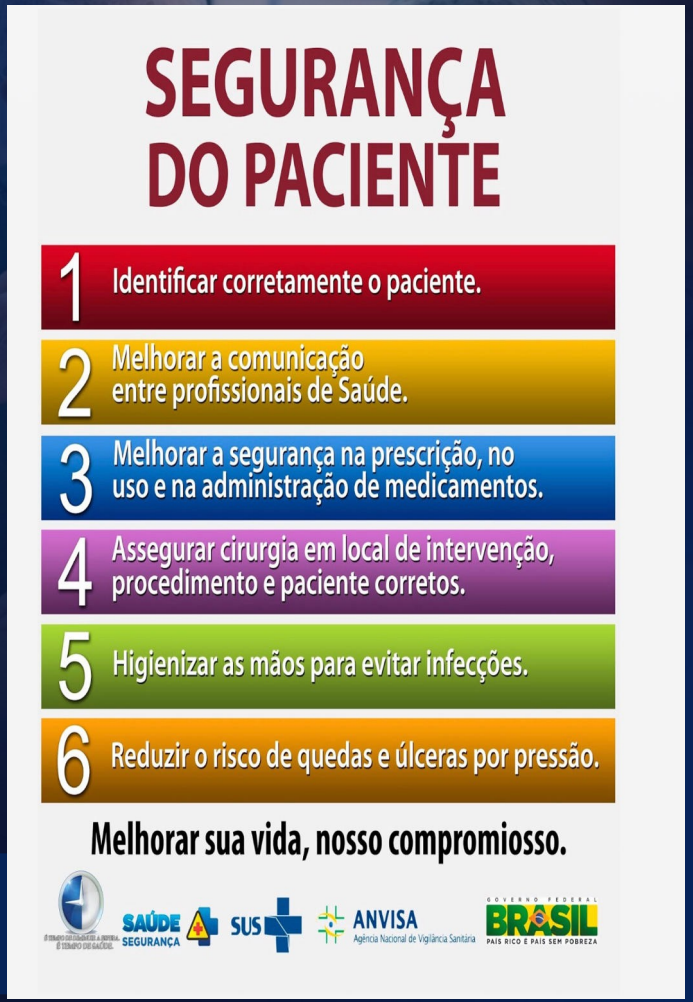
"Um mundo onde ninguém é prejudicado na assistência à saúde, e todo paciente recebe cuidados seguros e respeitosos, todas as vezes, em todos os lugares"

O quadro inclui sete objetivos estratégicos, que podem ser alcançados através de 35 estratégias específicas:

1. Fazer do zero dano evitável aos doentes um estado de espírito e uma regra fundamental no planeamento e prestação de cuidados de saúde em todo o lado
2. Construir sistemas de saúde de elevada confiabilidade e organizações de saúde que protegem, os doentes e utilizadores, diariamente de danos
3. Garantir a segurança de todos os processos clínicos
4. Envolver e capacitar doentes e famílias para ajudar e apoiar no caminho rumo a uma segurança nos cuidados de saúde mais efetiva
5. Inspirar, educar/formar, capacitar e proteger os profissionais de saúde para contribuir para a concepção e prestação de sistemas de cuidados seguros
6. Assegurar um fluxo constante de informação e conhecimentos para impulsionar a mitigação dos riscos, a redução dos níveis de danos evitáveis e a melhoria na segurança dos cuidados
7. Desenvolver e manter sinergias, parcerias e solidariedade multissetoriais e multinacionais para melhorar a segurança do doente e a qualidade dos cuidados

Metas Internacionais da Segurança do Paciente

World Health Organization



Segurança do Paciente

O **Programa Nacional de Segurança do Paciente** propõe um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde – eventos ou circunstâncias que poderiam resultar ou que resultaram em dano desnecessário para o paciente.

Por exemplo, queda de paciente da cama, aplicação errada de medicamento, falhas durante a cirurgia, etc. Esses problemas podem causar danos à saúde do paciente e devem ser comunicados à Anvisa. A Agência é o órgão do Ministério da Saúde responsável pelo recebimento das informações. Com isso, a Anvisa poderá propor ações visando a melhoria da qualidade dos estabelecimentos, de acordo com a Resolução RDC nº 36, de 25/07/13

Este espaço é um dos canais pelos quais a Anvisa pode receber essas informações sobre qualquer situação que tenha prejudicado a saúde de alguém durante a internação/atendimento. Profissionais de saúde, pacientes, familiares e acompanhantes: sua contribuição é muito importante para melhorar a assistência à saúde de todos os usuários dos estabelecimentos de saúde do Brasil. Faça a sua notificação para a Anvisa.

Notificações

Covid-19

Cadastros

Núcleos de Segurança do Paciente

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013

Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP).



Ministér&#65533;rio da Sa&#65533;de
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 36, DE 25 DE JULHO DE 2013

Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências.



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 10/06/2026 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 164

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 11.527, DE 9 DE JUNHO DE 2026

Institui a Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente.

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013

Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP).



Art. 4º Para fins desta Portaria, são adotadas as seguintes definições:

.....;

III - incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente;

IV - Evento adverso: incidente que resulta em dano ao paciente;

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013

Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP).



Art. 4º Para fins desta Portaria, são adotadas as seguintes definições:

.....

V - Cultura de Segurança: configura-se a partir de cinco características operacionalizadas pela gestão de segurança da organização:

a) cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares

b) cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais



Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013

Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP).

Art. 4º Para fins desta Portaria, são adotadas as seguintes definições:

.....

c) cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança



d) cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional

e) cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança

Taxonomia da segurança do paciente: classificação pelo dano

Circunstância notificável

Risco de dano, sem incidente.

Quase evento (near miss)

Interceptado antes de atingir o paciente.

Incidente sem dano

Atinge o paciente, sem dano.

Incidente com dano

Evento adverso: atinge e causa dano.

Sem incidente

Incidente de segurança do paciente

Evento sentinela: morte ou dano grave; exige investigação imediata.
Never events: evitáveis e inaceitáveis (ex.: cirurgia em local errado).

Fontes: OMS. International Classification for Patient Safety (ICPS) v1.1, 2009; Mendes W. In: Sousa P, Mendes W, orgs. Segurança do paciente. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2014. cap. 3. Evento sentinela: Joint Commission. Never events: National Quality Forum.

Erro é do processo; evento adverso é do desfecho

	Com erro	Sem erro
Com dano	**Evento adverso evitável** O erro atravessou as barreiras.	**Evento adverso não evitável** Complicação inerente ao cuidado.
Sem dano	**Quase evento ou incidente sem dano** Barreira interceptou, ou não houve dano.	**Cuidado sem incidente** Nada a notificar.

Erro (processo)
Falha não intencional na execução (deslize, lapso) ou no planejamento (engano).

Evento adverso (desfecho)
Incidente que causa dano ao paciente, decorrente do cuidado e não da doença.

Violação
Desvio deliberado de norma; não é erro.

Fontes: Reason J. Human Error, 1990; Sousa P, Mendes W, orgs. Segurança do paciente. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2014. caps. 3–5; OMS, ICPS v1.1, 2009.

O Humano e suas Violações



- Desvios deliberados de regras ou códigos
- Sua variedade e causas são consideradas de diferentes perspectivas
- Diferem de erros decorrentes de escolhas deliberadas
- Decisões conscientes que parecem oferecer ao transgressor algum tipo de benefício
- Na atenção à saúde geralmente não são feitos inteiramente de forma gratuita, eles são muitas vezes gerados por restrições operacionais significativas e falhas do sistema de atendimento

Complacência com violações

Desvios deliberados da prática, ainda que não necessariamente repreensíveis

Rotina

Excepcionais
(tempo, estresse)

Otimização
(vantagem pessoal)

Situacional
(falta de equipamento

Principais Pontos da RDC 36/2013

- **Objetivo:** Promover a segurança do paciente e reduzir ao mínimo aceitável o risco de danos na assistência à saúde
- **Núcleo de Segurança do Paciente (NSP):** Obriga os serviços de saúde a criarem um NSP para implementar ações de gestão de risco e monitorar incidentes
- **Plano de Segurança do Paciente (PSP):** Exige a elaboração e manutenção de um PSP com estratégias de gestão de risco

Principais Pontos da RDC 36/2013

- **Notificações pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NPS)**
  - Eventos adversos gerais: Devem ser notificados mensalmente à Anvisa (até o 15º dia útil do mês subsequente)
  - Eventos com óbito: Devem ser notificadas em até 72 horas
  - RDC exclui, entre outros, consultórios individualizados, laboratórios clínicos, serviços móveis e atenção domiciliar



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 10/06/2026 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 164

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 11.527, DE 9 DE JUNHO DE 2026

Institui a Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

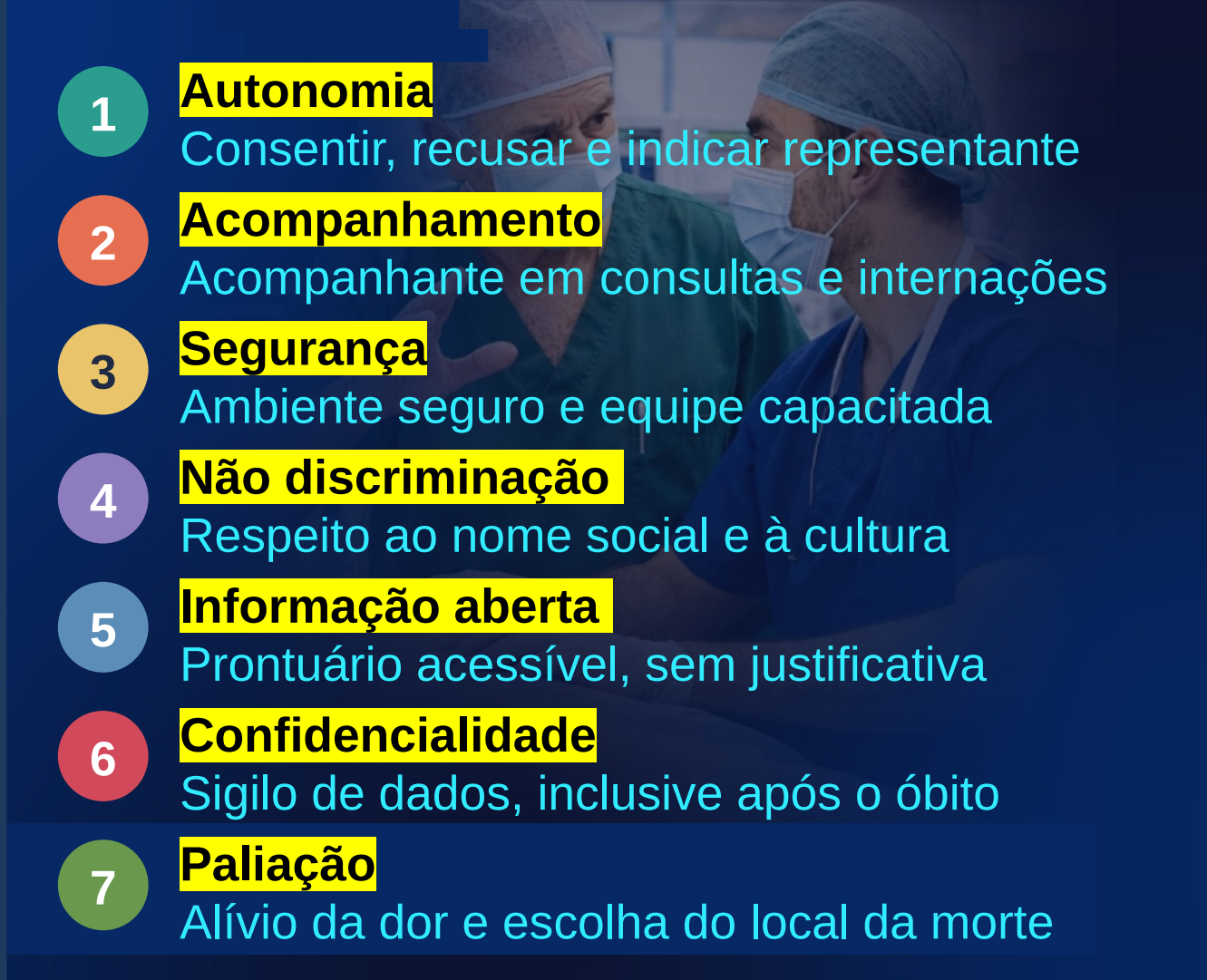
Publicado em: 07/04/2026 | Edição: 65 | Seção: 1 | Página: 1

Órgão: Atos do Poder Legislativo

LEI Nº 15.378, DE 6 DE ABRIL DE 2026

Institui o Estatuto dos Direitos do Paciente.

Sete pilares de proteção na jornada do usuário



1. **Autonomia**
   Consentir, recusar e indicar representante
2. **Acompanhamento**
   Acompanhante em consultas e internações
3. **Segurança**
   Ambiente seguro e equipe capacitada
4. **Não discriminação**
   Respeito ao nome social e à cultura
5. **Informação aberta**
   Prontuário acessível, sem justificativa
6. **Confidencialidade**
   Sigilo de dados, inclusive após o óbito
7. **Paliação**
   Alívio da dor e escolha do local da morte

Lei nº 15.378/2026: Estatuto dos Direitos do Paciente

Consentimento Informado na Assistência

Predisposição do Paciente	Relação risco-benefício favorável	Relação risco-benefício desfavorável
Aceitação	exigência de baixa capacidade	exigência de alta capacidade
Recusa	exigência de alta capacidade	exigência de baixa capacidade

Código de Ética Médica e ao art. 14 da Lei nº 15.378/2026

ent to

Autoridade
Poder
Persuação
Coerção

Pré-condições
Voluntariedade na decisão

Indivíduo livre de coerção de:

- Médico
- Pesquisador
- Outros profissionais de saúde
- Familiares
- Amigos
- Da própria sociedade (mídia)

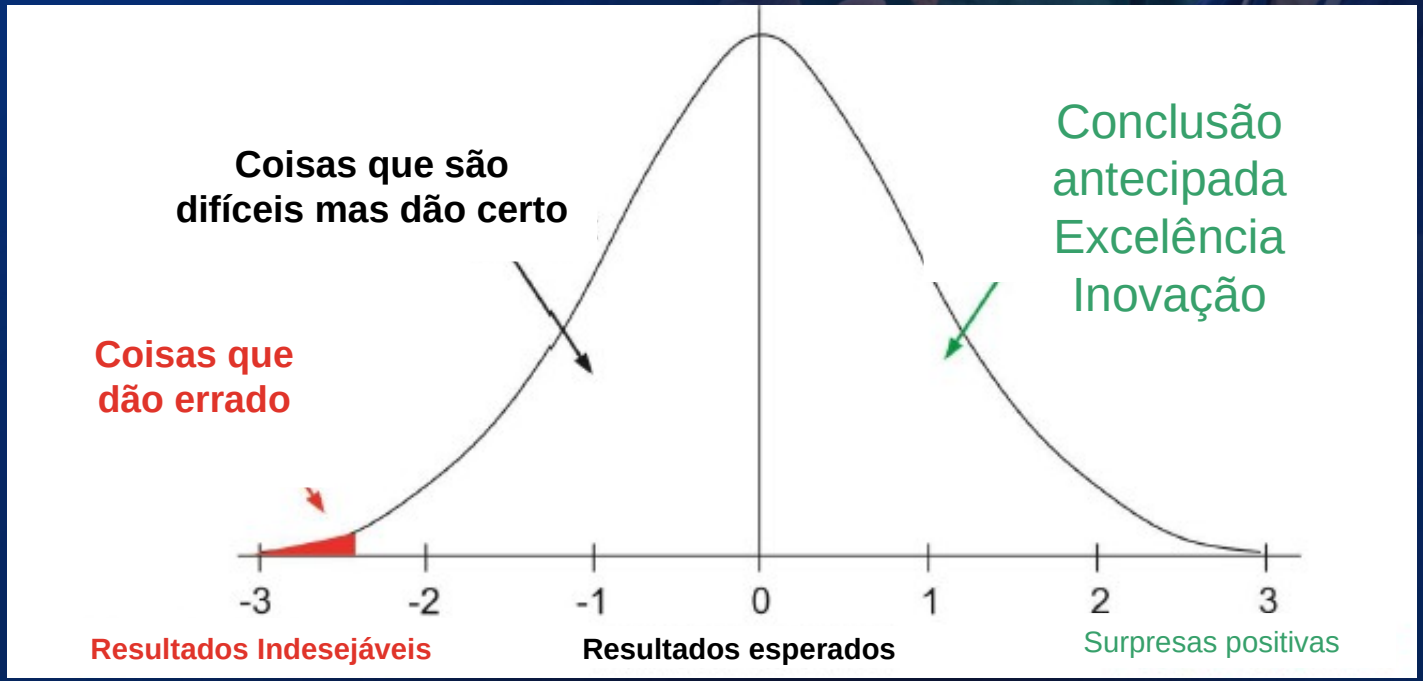
MÓDULO 2

Indicadores em Anestesia

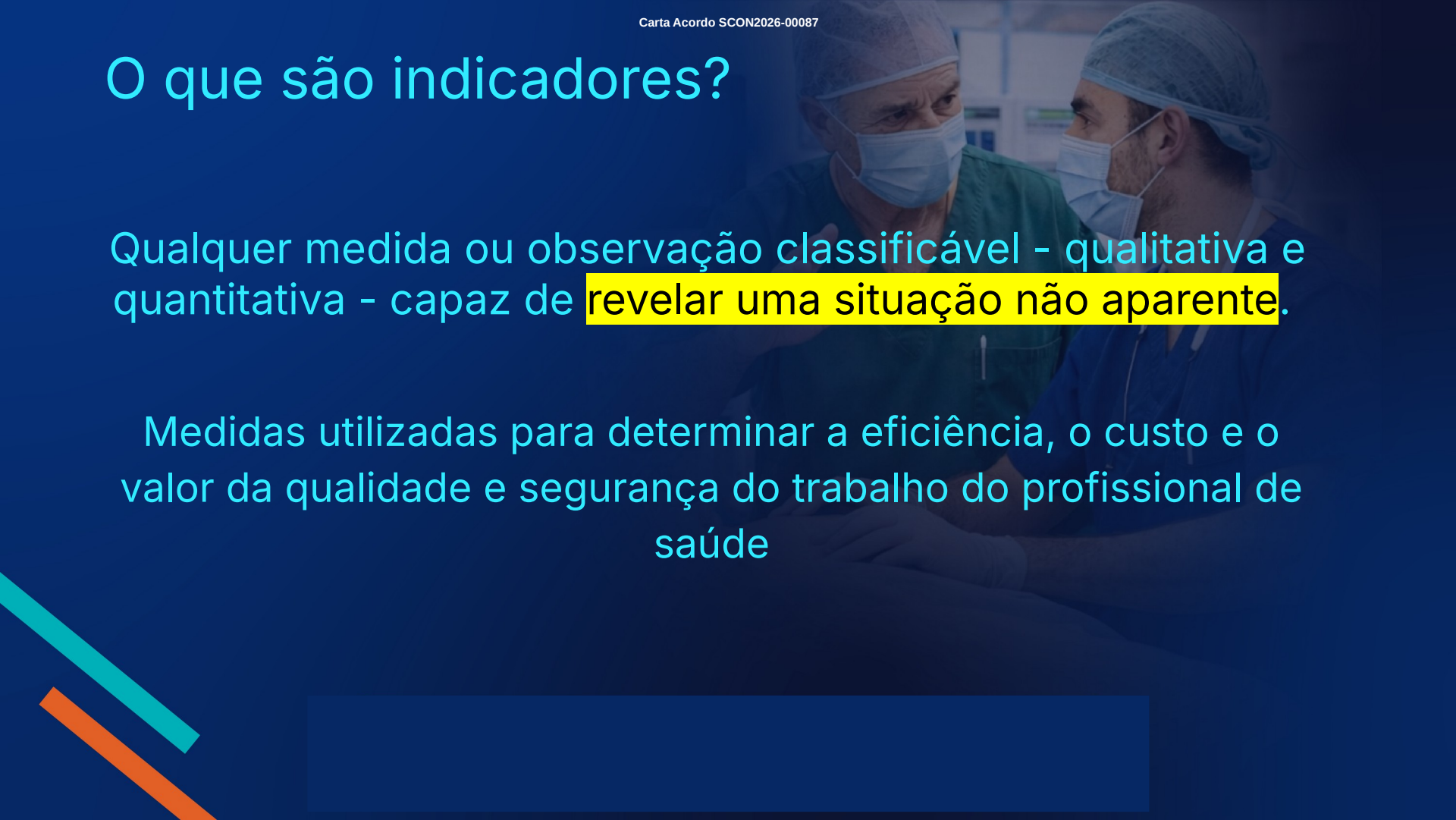
- Tríade de Donabedian
- Gestão guiada por dados
- Indicadores de Estrutura e Processo

A maioria de nós gosta de saber que estamos fazendo um bom trabalho

Como sabemos se estamos fazendo um bom trabalho?



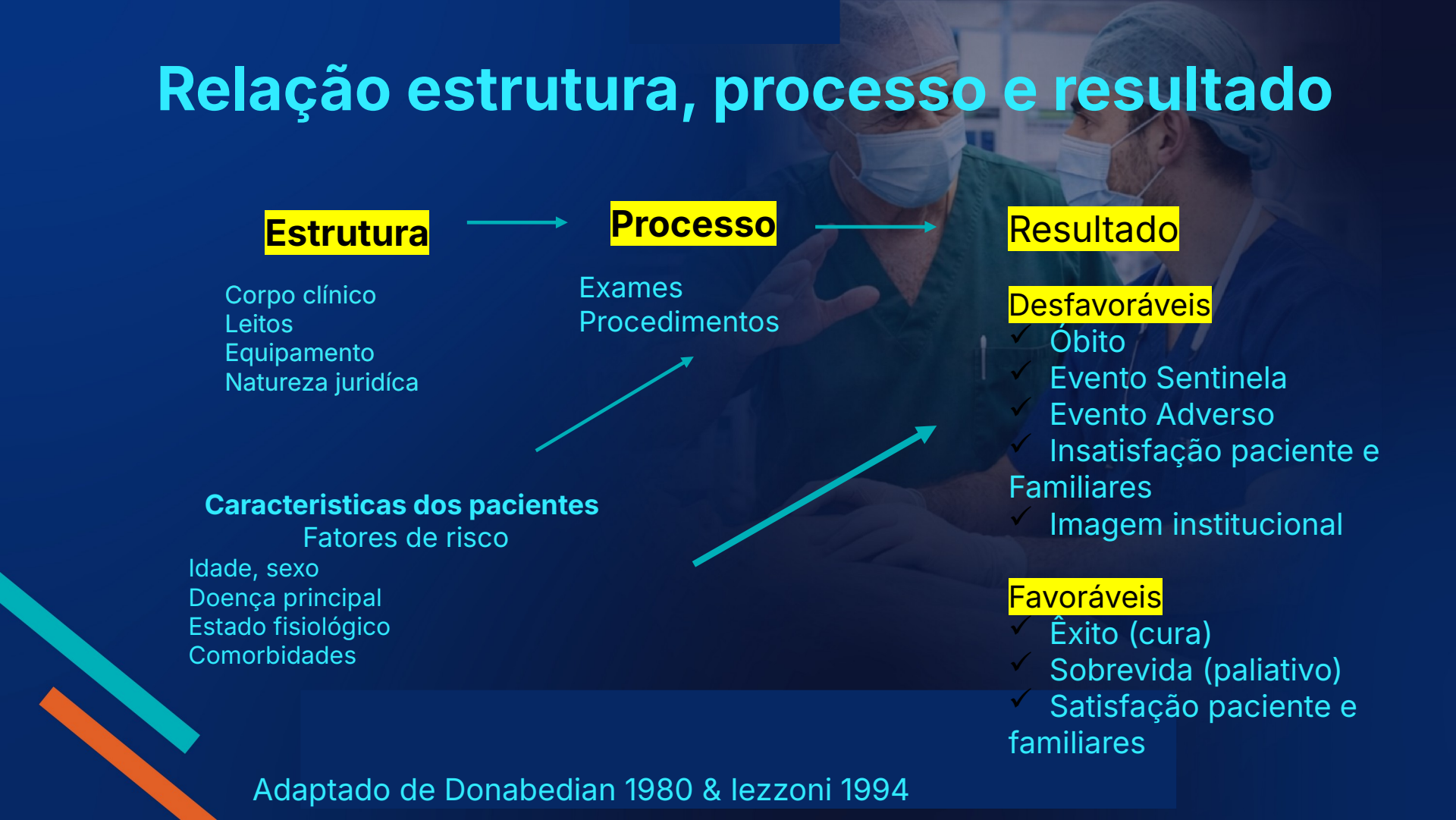
O que são indicadores?



Qualquer medida ou observação classificável - qualitativa e quantitativa - capaz de revelar uma situação não aparente.

Medidas utilizadas para determinar a eficiência, o custo e o valor da qualidade e segurança do trabalho do profissional de saúde

Relação estrutura, processo e resultado



Estrutura

Corpo clínico
Leitos
Equipamento
Natureza juridíca

Processo

Exames
Procedimentos

Caracteristicas dos pacientes
Fatores de risco
Idade, sexo
Doença principal
Estado fisiológico
Comorbidades

Resultado

Desfavoráveis
- ✓ Óbito
- ✓ Evento Sentinela
- ✓ Evento Adverso
- ✓ Insatisfação paciente e Familiares
- ✓ Imagem institucional

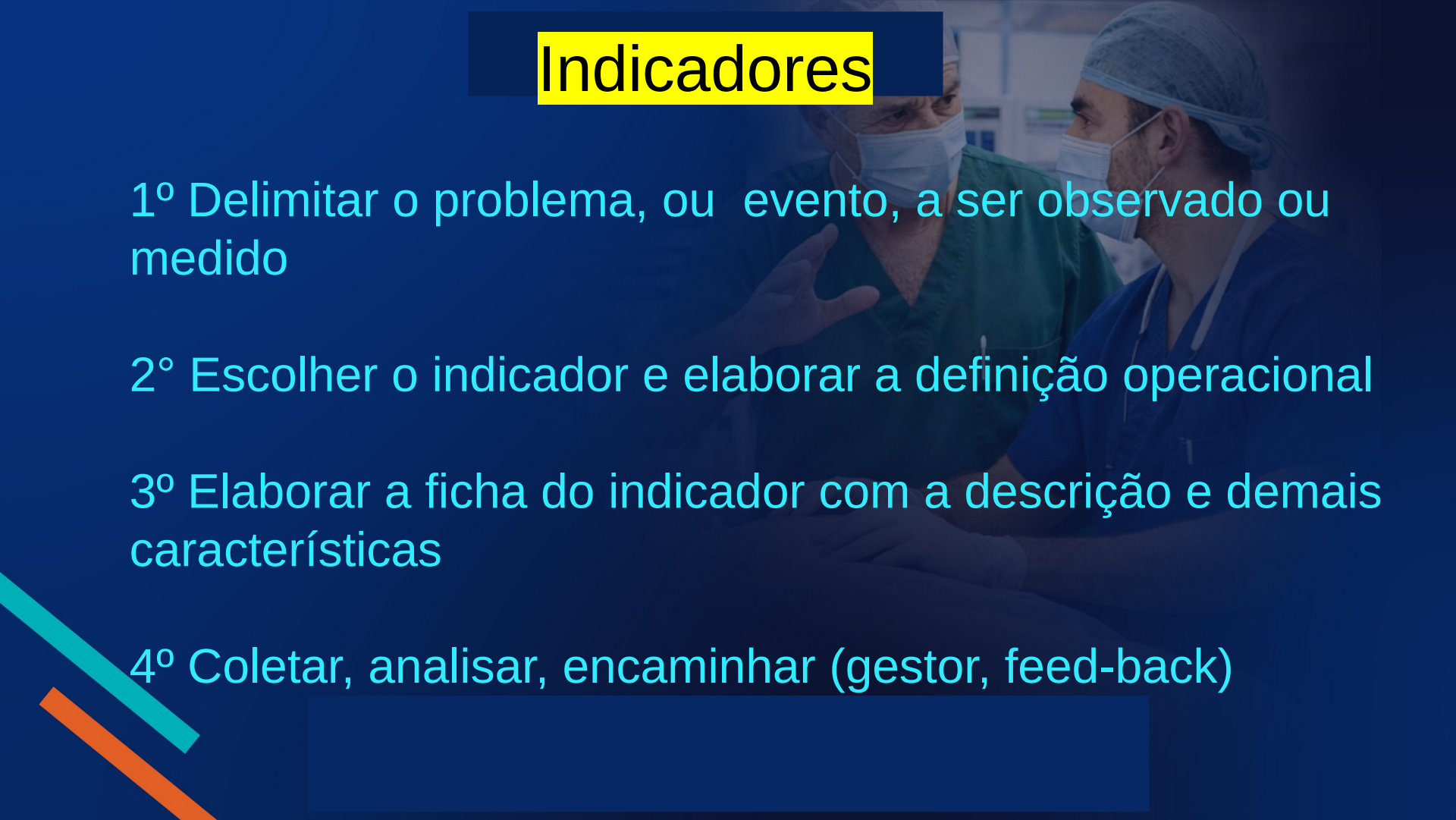
Favoráveis
- ✓ Êxito (cura)
- ✓ Sobrevida (paliativo)
- ✓ Satisfação paciente e familiares

Adaptado de Donabedian 1980 & Iezzoni 1994

Tríade Donabedian

Estrutura	Processo	Resultado
Recursos humanos: Profissionais capacitados e em nº adequado	Consulta e avaliação pré-anestésica TCLE	Resultados clínicos: taxas de eventos adversos tais como erros de medicação ou complicações, como dor,náuseas e vômitos
Equipamentos e fármacos conforme Res. CFM 2174/17	Checklist segurança cirúrgica (time-out) Protocolos e diretrizes	Satisfação do paciente e familiares: avaliação da experiência do paciente durante a sua jornada
Instalações: disponibilidade de salas operatórias e de RPA	Controle da qualidade e segurança: ações corretivas para falhas identificadas Auditorias internas	Mortalidade em até 48 horas Reintubação Dor no pós-operatório imediato

Indicadores



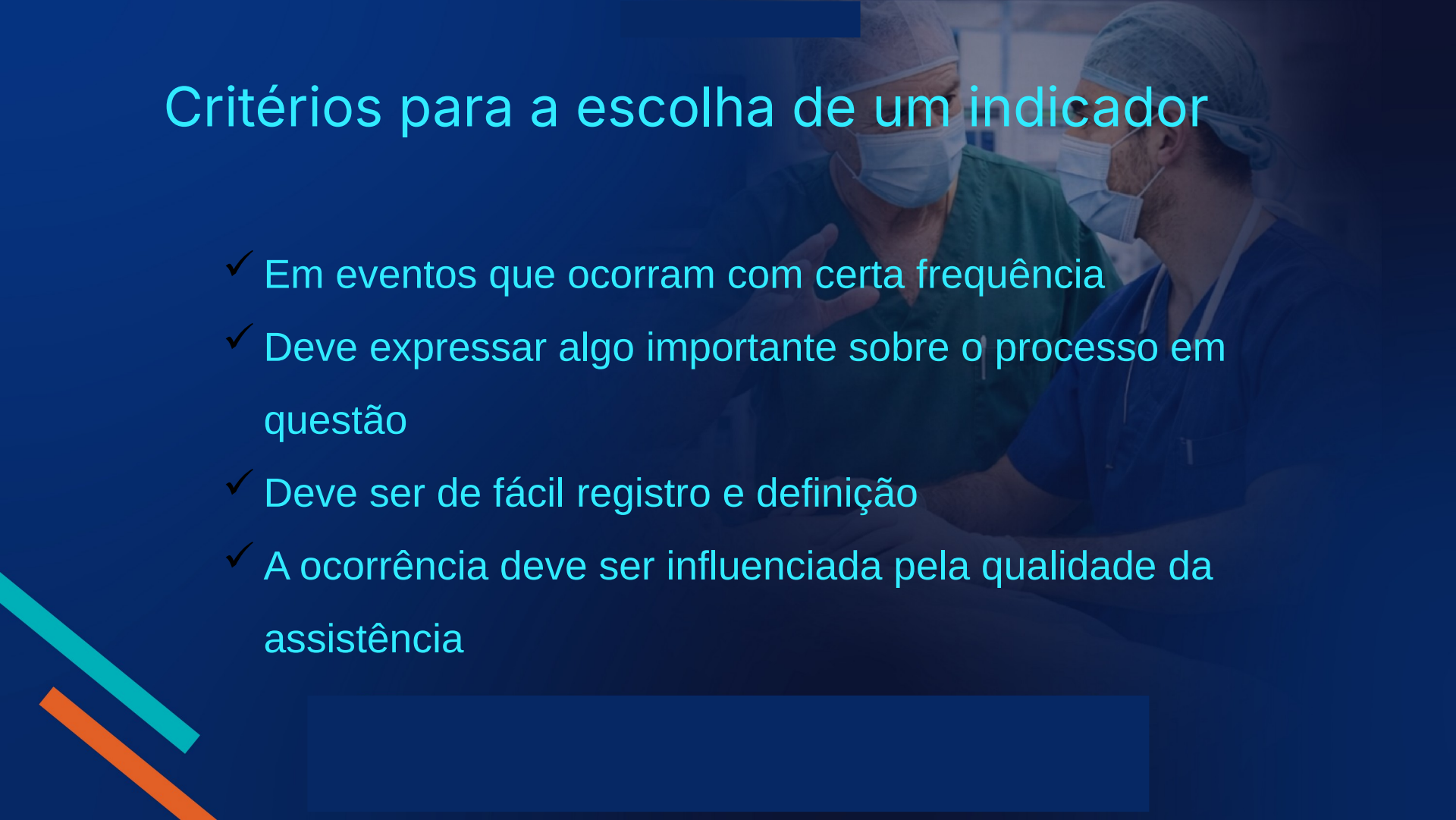
1º Delimitar o problema, ou evento, a ser observado ou medido

2° Escolher o indicador e elaborar a definição operacional

3º Elaborar a ficha do indicador com a descrição e demais características

4º Coletar, analisar, encaminhar (gestor, feed-back)

Critérios para a escolha de um indicador



- ✓ Em eventos que ocorram com certa frequência
- ✓ Deve expressar algo importante sobre o processo em questão
- ✓ Deve ser de fácil registro e definição
- ✓ A ocorrência deve ser influenciada pela qualidade da assistência

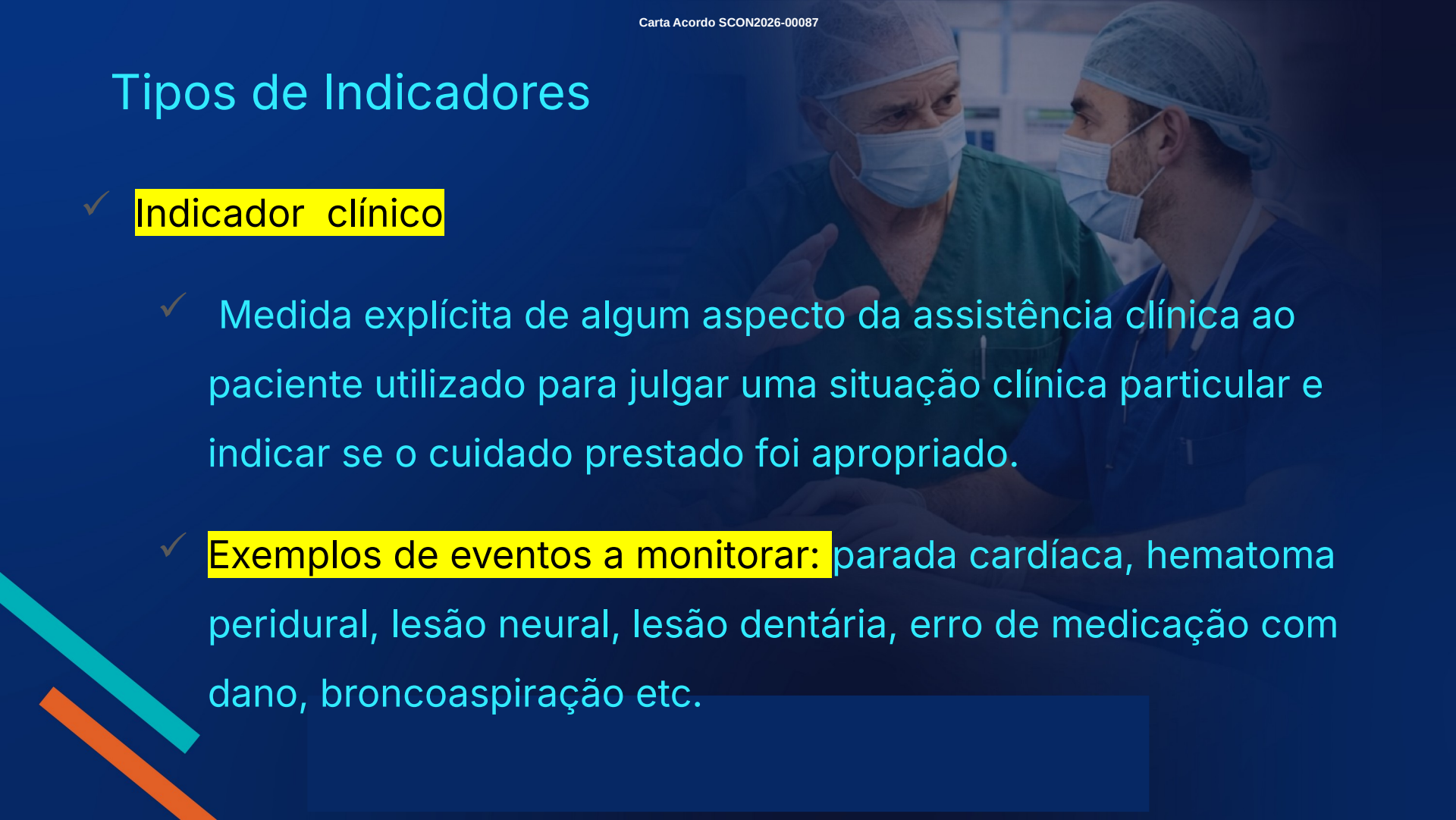
Algumas estratégias são utilizadas para a montagem dos indicadores

- ✓ Identificar e sensibilizar os atores de interesse
- ✓ Estabelecer quais processos devem ser mapeados e analisados
- ✓ Mapeamento dos processos (fluxogramas, infográficos, etc.)
- ✓ Identificar a estrutura, o processo ou o resultado a ser monitorado
- ✓ identificar os pontos críticos que devem ser monitorados em cada processo

Propriedades dos Indicadores

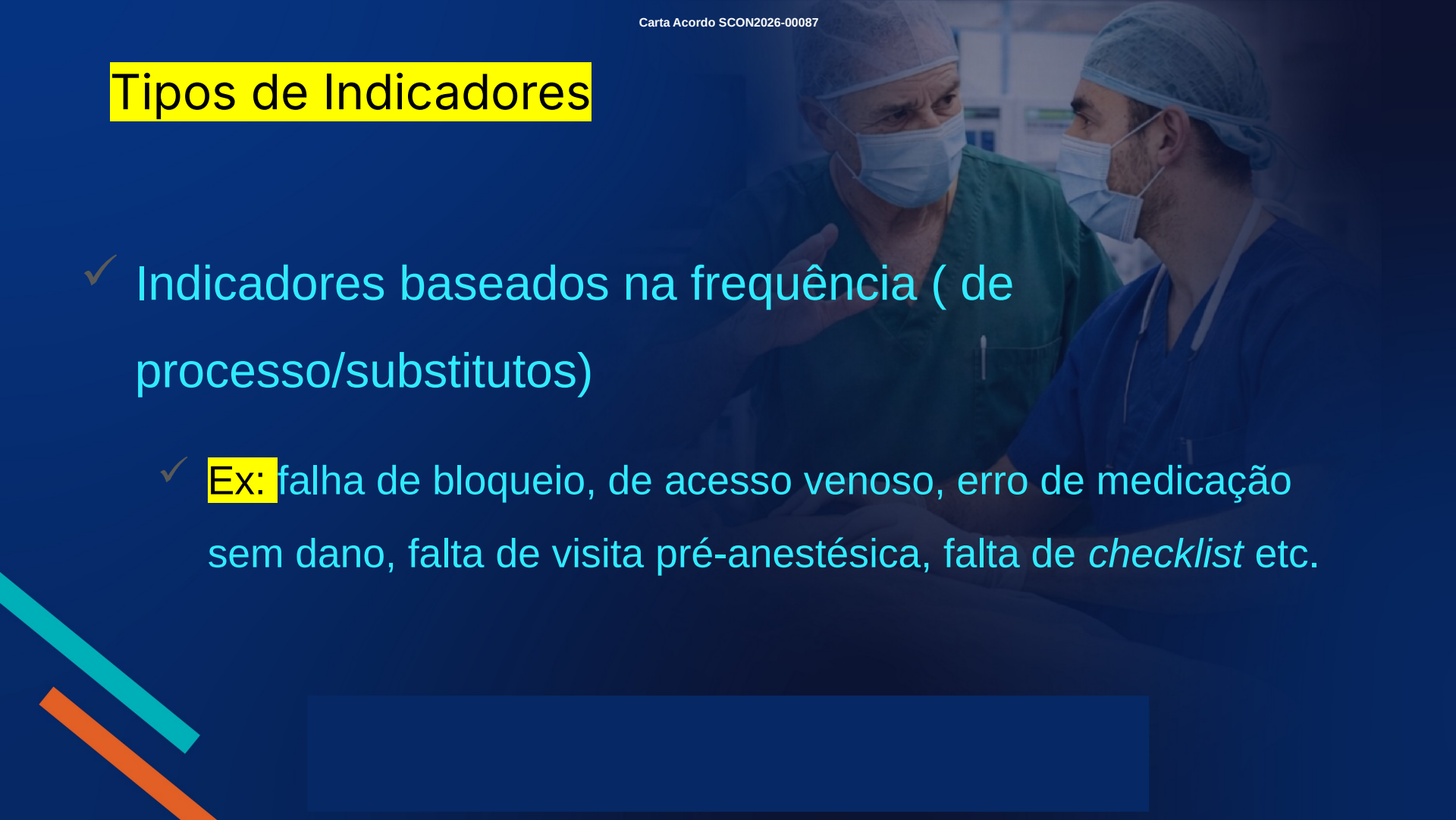
- ✓ Validação/Pertinência → adequação do indicador em medir ou representar, sinteticamente, o fenômeno estudado.
- ✓ Especificidade → discriminar um evento de outros
- ✓ Facilidade/Disponibilidade → são simples de buscar e calcular
- ✓ Rastreabilidade → identificação da origem dos dados
- ✓ Sensibilidade → detecção de variações ocasionais
- ✓ Estabilidade → permanência no tempo
- ✓ Baixo custo de obtenção

Tipos de Indicadores

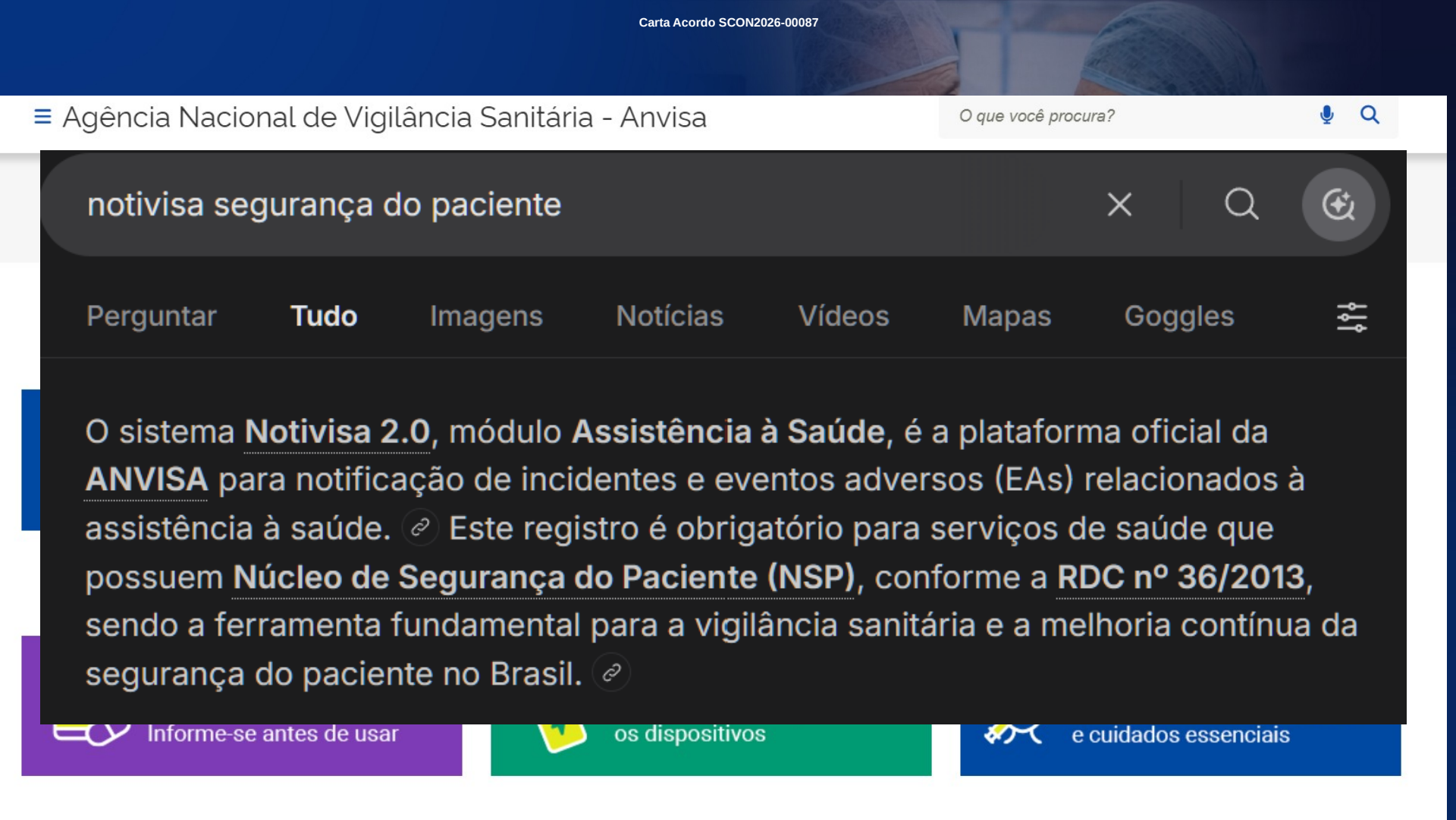


- Indicador clínico
  - Medida explícita de algum aspecto da assistência clínica ao paciente utilizado para julgar uma situação clínica particular e indicar se o cuidado prestado foi apropriado.
  - Exemplos de eventos a monitorar: parada cardíaca, hematoma peridural, lesão neural, lesão dentária, erro de medicação com dano, broncoaspiração etc.

Tipos de Indicadores



- Indicadores baseados na frequência (de processo/substitutos)
  - Ex: falha de bloqueio, de acesso venoso, erro de medicação sem dano, falta de visita pré-anestésica, falta de *checklist* etc.


Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa
O que você procura?
notivisa segurança do paciente
Perguntar
Tudo
Imagens
Notícias
Vídeos
Mapas
Goggles
O sistema Notivisa 2.0, módulo Assistência à Saúde, é a plataforma oficial da ANVISA para notificação de incidentes e eventos adversos (EAs) relacionados à assistência à saúde. Este registro é obrigatório para serviços de saúde que possuem Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), conforme a RDC nº 36/2013, sendo a ferramenta fundamental para a vigilância sanitária e a melhoria contínua da segurança do paciente no Brasil.
Informe-se antes de usar
os dispositivos
e cuidados essenciais

https://www.who.int/data/gho/data/themes/global-patient-safety-observatory

Global Regiões

World Health Organization

Temas de Saúde Países Redação Emergências

O OBSERVATÓRIO GLOBAL DE SAÚDE

Explore um mundo de dados de saúde

GHO Home Indicadores Países API de dados Galeria de Mapas Publicações

Dados / GHO / Temas

Observatório Global de Segurança do Paciente

A notificação pode ser realizada por profissionais de saúde (NSPs) ou diretamente por **cidadãos** (pacientes, familiares e cuidadores) sem necessidade de cadastro prévio. O sistema utiliza a **Classificação Internacional para Segurança do Paciente da OMS** e exige o preenchimento de etapas obrigatórias (tipos de incidente, consequências e características) e complementares para investigações aprofundadas.

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 09/2025

Orientações gerais para a notificação de incidentes relacionados à assistência à saúde

1. Sistema de Informação 6
2. Fluxo da notificação 8
3. Como é estruturado o Sistema NOTIVISA 2.0 (módulo assistência à saúde)? 9
4. Quem deve notificar? 10
5. Como realizar o cadastro do Núcleo de Segurança do Paciente? 11
6. Como acessar o sistema NOTIVISA 2.0 e informações importantes para a notificação? 18
7. O que deve ser notificado no módulo de ASSISTÊNCIA À SAÚDE? 21
8. Quais os prazos para notificação e investigação no sistema NOTIVISA? 24

Cidadão (pacientes, familiares)

Publicado em 23/12/2020 14h03 | Atualizado em 29/04/2025 09h48

Compartilhe:

Os cidadãos (pacientes, familiares, cuidadores, usuários de serviços de saúde) podem relatar incidentes / falhas decorrentes da assistência à saúde em formulário especifico no sistema Notivisa. Não é necessário cadastro prévio.

Entende-se por incidente, o evento ou a circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde e por evento adverso, o incidente que resultou em dano à saúde.

A notificação do cidadão é voluntária e, compartilhando sua experiência, você contribuirá para o desenvolvimento de medidas corretivas que possam evitar que danos aos pacientes em serviços de saúde venham a se repetir, melhorando a qualidade e a segurança do paciente nestes serviços.

Os dados sobre os notificadores são confidenciais, obedecidos os dispositivos legais, e sua guarda é de responsabilidade do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

A identificação do notificador é importante para que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária possa esclarecer dúvidas referentes à notificação realizada, mas **não será divulgada para o serviço de saúde**.

Sua notificação não será analisada individualmente e não resultará na punição dos envolvidos.

Notificar eventos adversos de medicamentos e vacinas no VigiMed



O VigiMed é o sistema disponibilizado pela Anvisa para que cidadãos, profissionais de saúde, detentores de registro de medicamentos e patrocinadores de estudos possam reportar suspeitas de eventos adversos relacionados a medicamentos e vacinas.

O que pode ser considerado evento adverso?

Qualquer ocorrência médica indesejável devido ao uso de medicamentos ou vacinas, tais como:

* Reações adversas ou nocivas

*Ausência ou redução do efeito esperado (inefetividade terapêutica)

*Erros de medicação (relacionados à prescrição, preparação, dispensação, distribuição, administração e monitoramento dos medicamentos) interceptados ou ocorridos;

*Uso abusivo

*Uso com finalidade diferente do indicado na bula (off label)

*Intoxicação

Principais Eventos Adversos em Anestesia

Pré-anestésica (falhas)

Identificação, reserva de leito na UTI, hemocomponentes, identificação de via aérea difícil, etc.

Durante o procedimento

Trauma dentário, erro de medicação, aspiração pulmonar, hipotermia, hipoxemia, hipercapnia, lesão nervosa, sobredose AL, queda da mesa cirúrgica, embolia gasosa, etc.

Pós-anestésico

Hipotermia, dor, dessaturação, náuseas, vômitos, etc.

Indicador de Processo | Avaliação pré-anestésica

$$\text{Percentual (\%)} = \frac{\text{casos com avaliação e plano registrados}}{\text{Total de anestesia iniciadas no período}} \times 100$$

Ex: 17 avaliações em 20 cirurgias = 85%

Itens de Ficha do Indicador

Finalidade: monitorar se a avaliação pré-anestésica e o plano estão registrados antes do início da anestesia; identificar barreiras no fluxo.
Numerador: número de casos com registro identificável, com data/hora, da avaliação pré-anestésica e do plano antes do início da anestesia.
Denominador: total de procedimentos anestésicos iniciados na unidade durante o mesmo período.
Exclusões: procedimentos cancelados antes de começar a anestesia. Incluir urgências e emergências, mas analisá-las separadamente das cirurgias eletivas.
Fonte e frequência: ficha anestésica ou prontuário; auditoria mensal.

Em serviço de baixo volume, revisar todos os casos; em volume maior, definir previamente uma amostra

Anesthesia Quality Institute

Print Contact Us Send Me Info

HOME ABOUT US QUALITY RESEARCH REGISTRIES JOIN NACOR

Introduction to NACOR | NACOR Dashboard | Standards & Validation | Send Me Info
Become a Vendor

NATIONAL ANESTHESIA CLINICAL OUTCOMES REGISTRY

The Anesthesia Quality Institute (AQI) is home to the National Anesthesia Clinical Outcomes Registry (NACOR), a data warehouse that has been designated as a Qualified Registry (QR) and a Qualified Clinical Data Registry (QCDR) by the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) for Physician Quality Reporting System (PQRS) reporting. With millions of cases and growing, AQI's clinical data provides an evidence-based rationale that informs treatment choices and helps control treatment costs.

NACOR is intended for all anesthesia providers, in all practice settings. The registry provides participating providers with:

- Custom continuous performance monitors
- Performance gap analysis and patient outlier identification
- Access to improvement interventions to close performance gaps including patient care management tools, targeted education, and links to anesthesia information technology vendors.
- Peer-to-peer benchmarks

Como os dados chegam ao Anesthesia Quality Institute

Práticas de anestesia

Hospitais e serviços

Software de faturamento, prontuário e AIMS (Anesthesia Information Management System)

AQI, programa da ASA

Anesthesia Incident Reporting System (AIRS)
Notificação de incidentes

National Anesthesia Clinical Outcome Registry (NACOR)
Registro de casos de anestesia

Closed Claims
Sinistros encerrados; no AQI desde 2019

Saídas do NACOR: painéis e benchmarks · pesquisa · reporte ao CMS (MIPS)

Fontes: ASA, Anesthesia Quality Institute (asahq.org/aqi); Dutton RP. AMA J Ethics. 2015;17(3):248-52; NACOR, Anesth Analg. 2015 (PMID 26579661).

AQI Recommended Indicators

These are the things you should report:

Business Indicators

- Cases done
  - By surgical service
  - By anesthesia type
  - By ASA class
  - By location
- Number of providers
  - By type (Physician, Resident, CRNA, AA, etc.)
  - By subspecialty training or group
- Total minutes billed
  - By surgical service
- Top ten cases done, and average duration

Process Indicators

- On-time starting percentage of first cases
  - By service/facility
- Cancellation rate
- Physician Quality Reporting System (PQRS) measure compliance
  - Prophylactic antibiotic administration
  - Adherence to central line bundle
  - Normothermia in the Post Anesthesia Care Unit (PACU)
- Documentation compliance (% of cases with completed QM records)



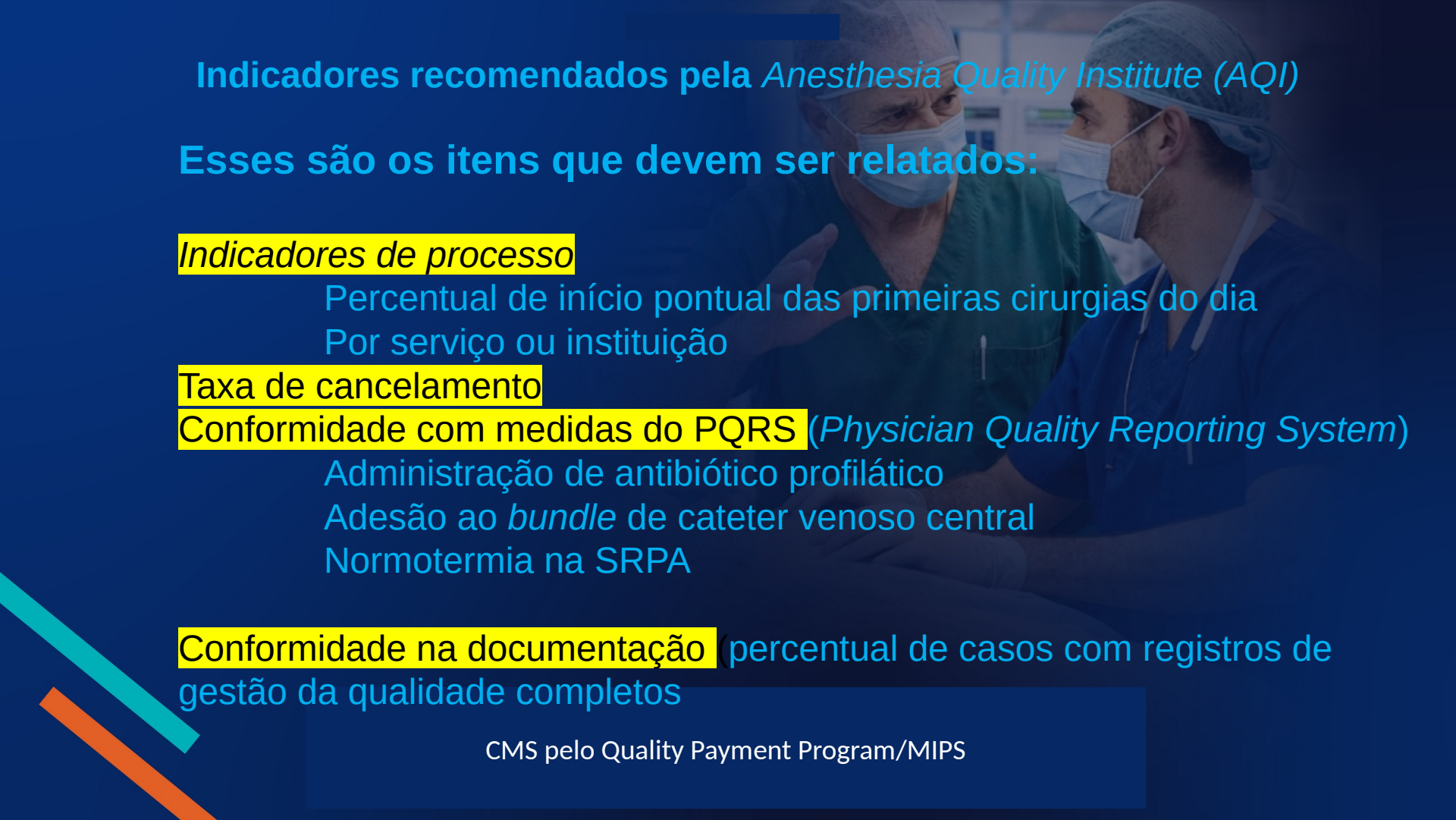
Indicadores recomendados pela *Anesthesia Quality Institute (AQI)*

Esses são os itens que devem ser relatados:

Indicadores de gestão (business)

- Casos realizados
  - Por serviço cirúrgico
  - Por tipo de anestesia
  - Por classificação ASA
  - Por local
- Número de profissionais
  - Por categoria (médico, residente, CRNA, AA etc.)
  - Por área de subespecialização ou grupo
- Total de minutos faturados
  - Por serviço cirúrgico
- Os dez casos mais frequentes e a duração média de cada um

CMS pelo Quality Payment Program/MIPS



Indicadores recomendados pela *Anesthesia Quality Institute (AQI)*

Esses são os itens que devem ser relatados:

Indicadores de processo

- Percentual de início pontual das primeiras cirurgias do dia
  - Por serviço ou instituição

Taxa de cancelamento

Conformidade com medidas do PQRS (*Physician Quality Reporting System*)

- Administração de antibiótico profilático
- Adesão ao *bundle* de cateter venoso central
- Normotermia na SRPA

Conformidade na documentação (percentual de casos com registros de gestão da qualidade completos

CMS pelo Quality Payment Program/MIPS

Clinical Outcome Indicators

- Number of cases completed uneventfully
- Number of each critical event occurring (by location/service):

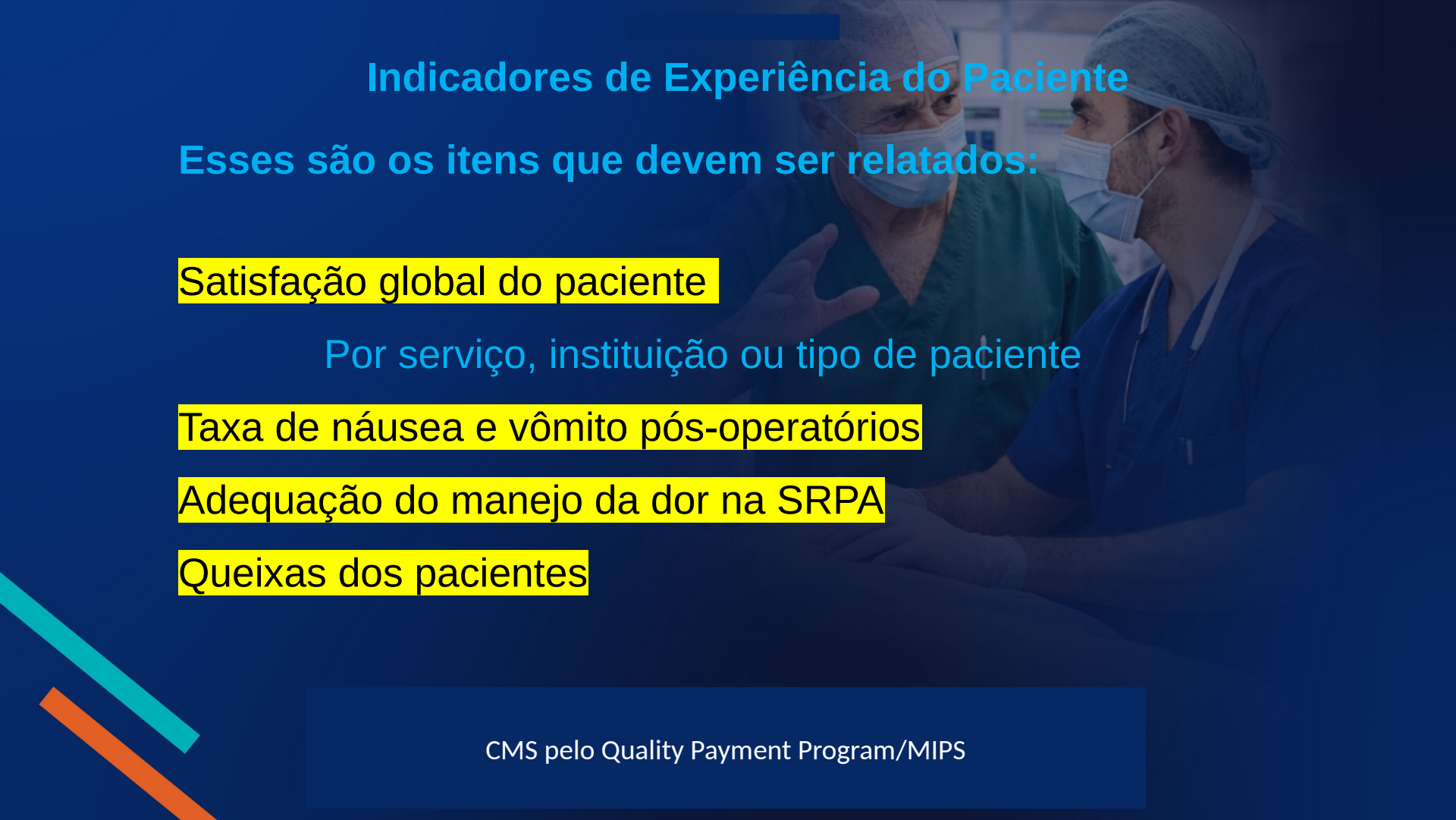
-Death	-Incorrect patient	-Vascular access complication
-Cardiac arrest	-Medication error	-Pneumothorax
-Perioperative MI	-Unplanned admission	-Infection after regional anesthesia
-Anaphylaxis	-Unplanned ICU admission	-Epidural hematoma
-Malignant hyperthermia	-Intraoperative awareness	-High spinal
-Transfusion reaction	-Unplanned difficult airway	-Postdural puncture headache
-New stroke	-Unplanned reintubation	-Local anesthetic toxicity
-Visual loss	-Dental trauma	-Peripheral neurologic deficit
-Incorrect surgical site	-Perioperative aspiration	

-Patient Experience Indicators

- -Overall patient satisfaction
  - -By service/facility/patient type
- -Rate of postoperative nausea and vomiting
- -Adequacy of pain management in the PACU
- -Patient complaints

Indicadores Desfecho Clínico

Nº casos concluídos sem intercorrências e Nº de cada evento crítico ocorrido por local		
Óbito	Paciente incorreto	Complicação de acesso vascular
Parada cardíaca	Erro de medicação	Pneumotórax
IAM perioperatório	Internação não planejada	Infecção após anestesia regional
Anafilaxia	Internação não planejada em UTI	Hematoma epidural
Hipertermia maligna	Consciência intraoperatória	Raquianestesia alta (high spinal)
Reação transfusional	Via aérea difícil não planejada	Cefaleia pós-punção dural
Novo AVC	Reintubação não planejada	Toxicidade por anestésico local
Perda visual	Trauma dentário	Déficit neurológico periférico
Sítio cirúrgico incorreto	Aspiração perioperatória	



Indicadores de Experiência do Paciente

Esses são os itens que devem ser relatados:

Satisfação global do paciente

Por serviço, instituição ou tipo de paciente

Taxa de náusea e vômito pós-operatórios

Adequação do manejo da dor na SRPA

Queixas dos pacientes

CMS pelo Quality Payment Program/MIPS

EVENTOS ADVERSOS

Total de procedime

Total de eventos ad

Paciente requer a colocação de tubo traqueal ou

cas ou

função

atória,

Extubação anestésico ao paciente imediata.

Aspiração de conteúdo gástrico com sintomatologia clínica e com achados radiológicos.

hipercapnia ou acidose respiratória.

anestesista dificuldade cara facial, dificuldade de **ais tentativas com sucesso)**

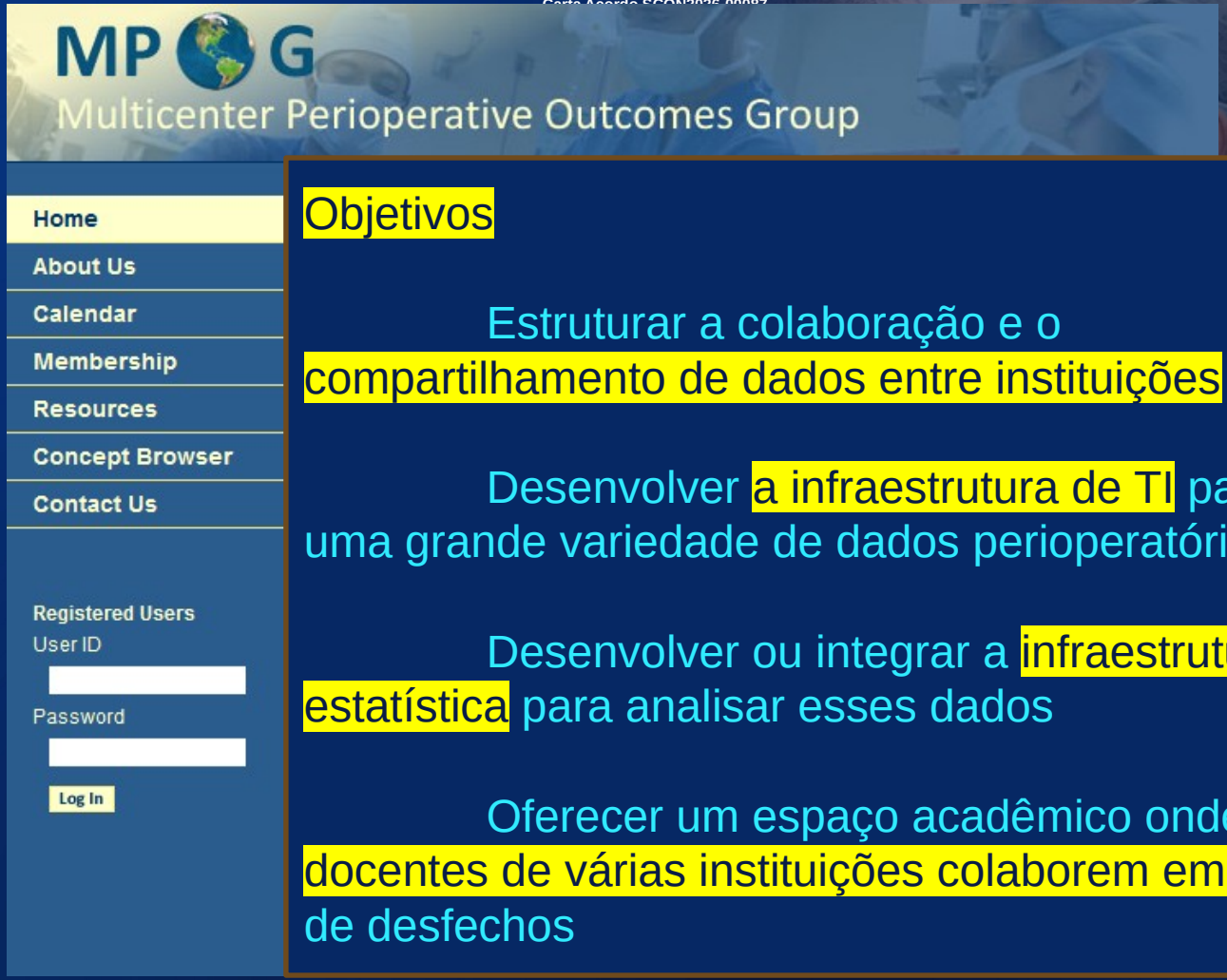
Trauma inesperado de dentes com extração total ou parcial

ou ambos.

Trauma dentário		
Via aérea difícil (VAD) não reconhecida	28	0,000344%

Material	Ocorrências	%
Anafilaxia	4	0,000049%
Ocorrência relacionada a Medicamentos (erro dispensação/ administração)	0	0,000000%
Queixa técnica (medicamentos/ materiais/ equipamentos)	4	0,000049%
Reação Transfusional perioperatória - RPA	0	0,000000%
Toxicidade por anestésico local	3	0,000037%

Sistema Cardiovascular	Ocorrências	%
Infarto agudo miocárdico no perioperatório	17	0,000209%
Óbito no Período Perioperatório	62	0,000763%
Parada Cardíaca no Período Perioperatório	75	0,000923%



Objetivos

Estruturar a colaboração e o compartilhamento de dados entre instituições

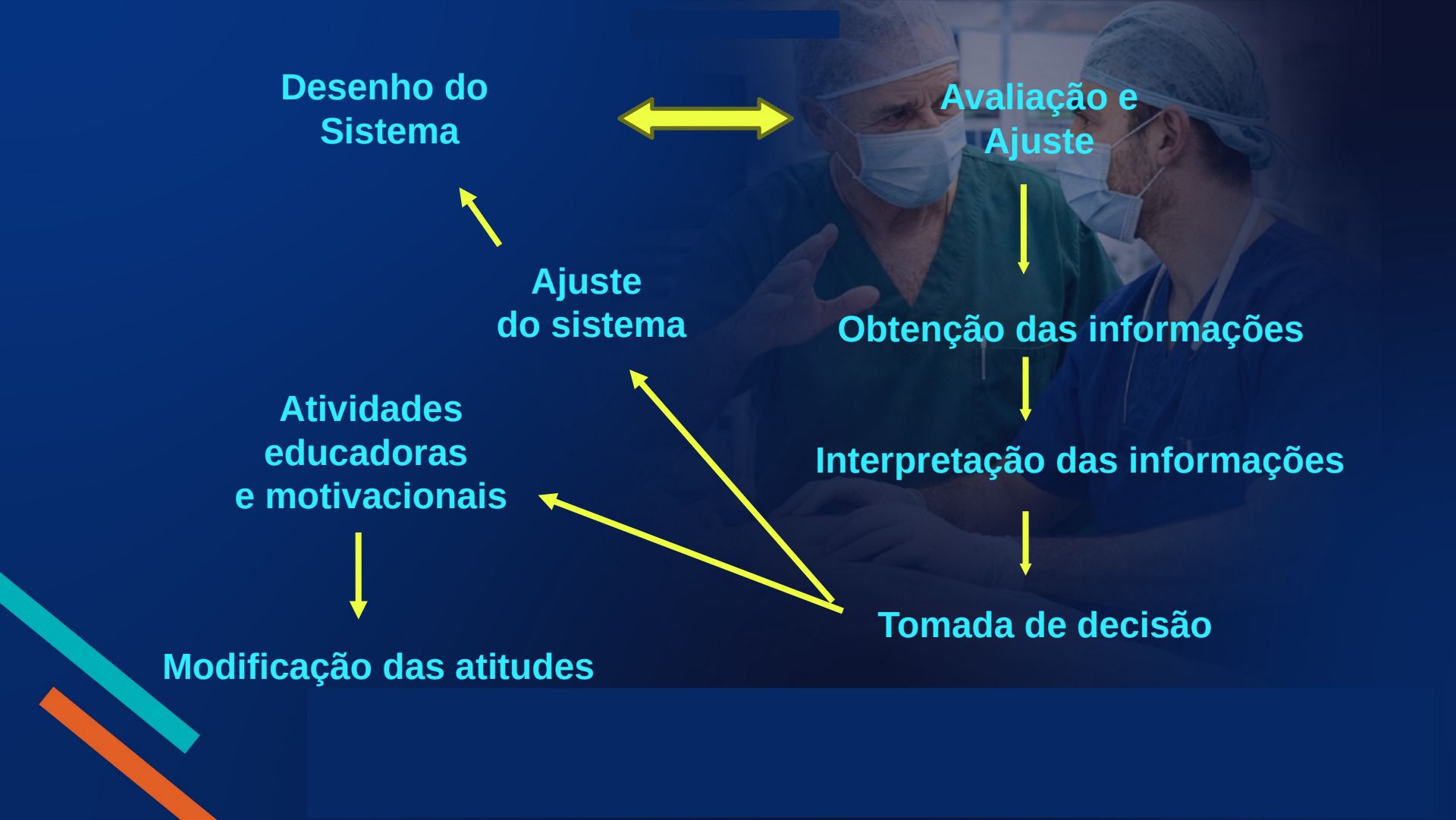
Desenvolver a infraestrutura de TI para reunir uma grande variedade de dados perioperatórios

Desenvolver ou integrar a infraestrutura estatística para analisar esses dados

Oferecer um espaço acadêmico onde docentes de várias instituições colaborem em pesquisa de desfechos



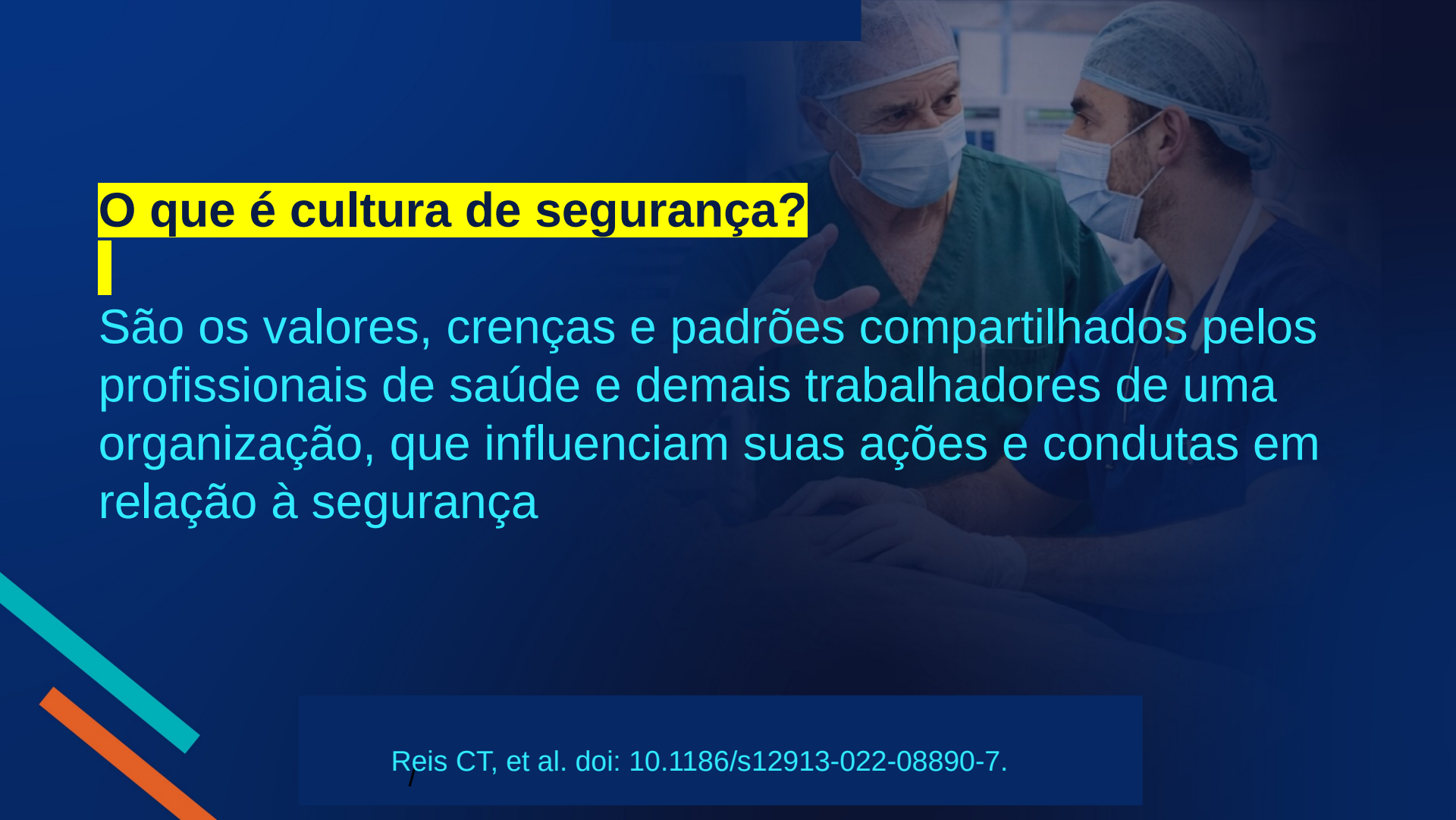
Registro de mais de 23 milhões de casos anestésicos, com dados de mais de 60 hospitais


Desenho do Sistema
Avaliação e Ajuste
Ajuste do sistema
Obtenção das informações
Atividades educadoras e motivacionais
Interpretação das informações
Tomada de decisão
Modificação das atitudes

MÓDULO 3

Cultura de Segurança

- Cinco estágios da maturidade
- Cultura Justa
- Evolução: Segurança I - Segurança II

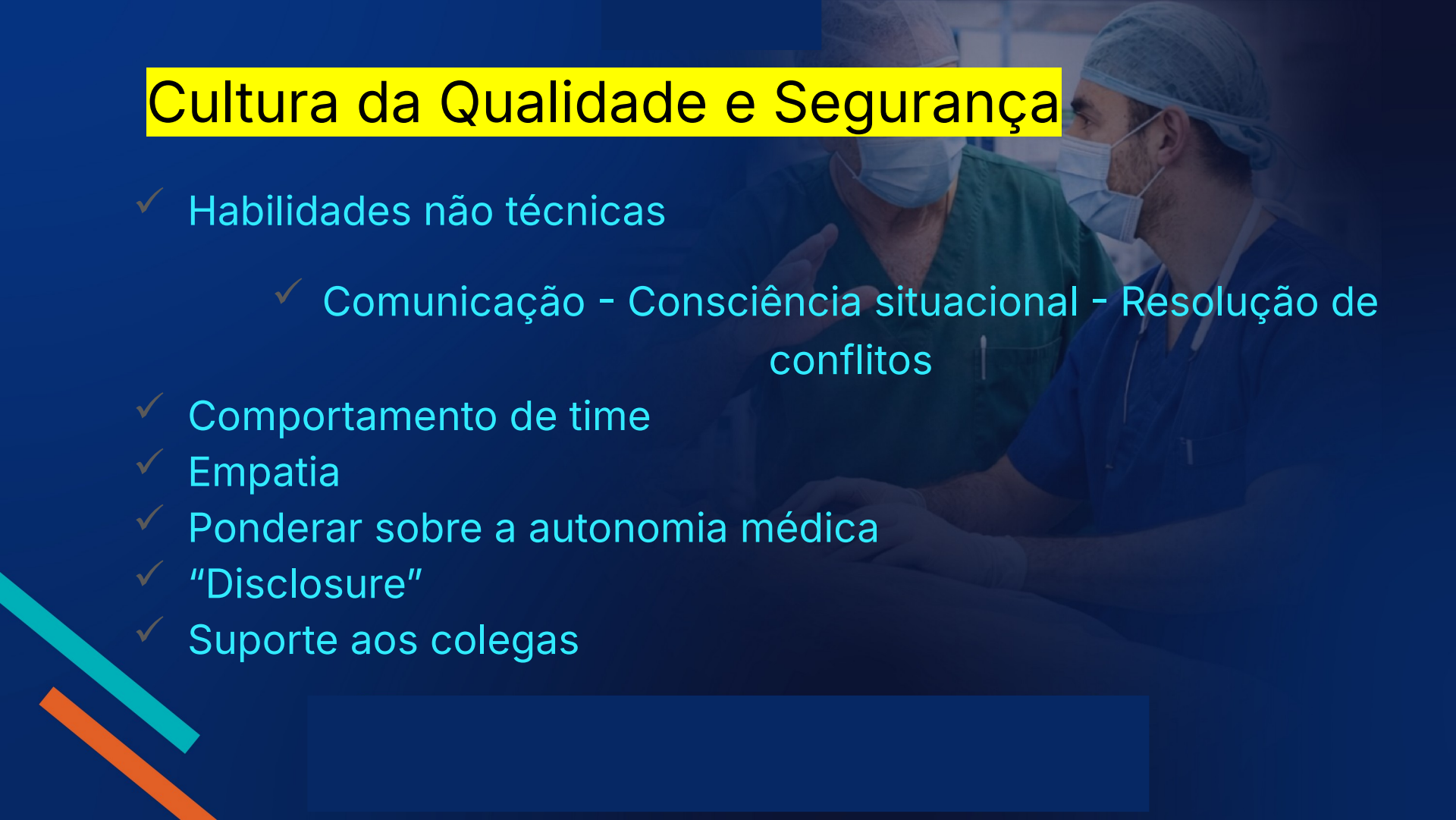


O que é cultura de segurança?

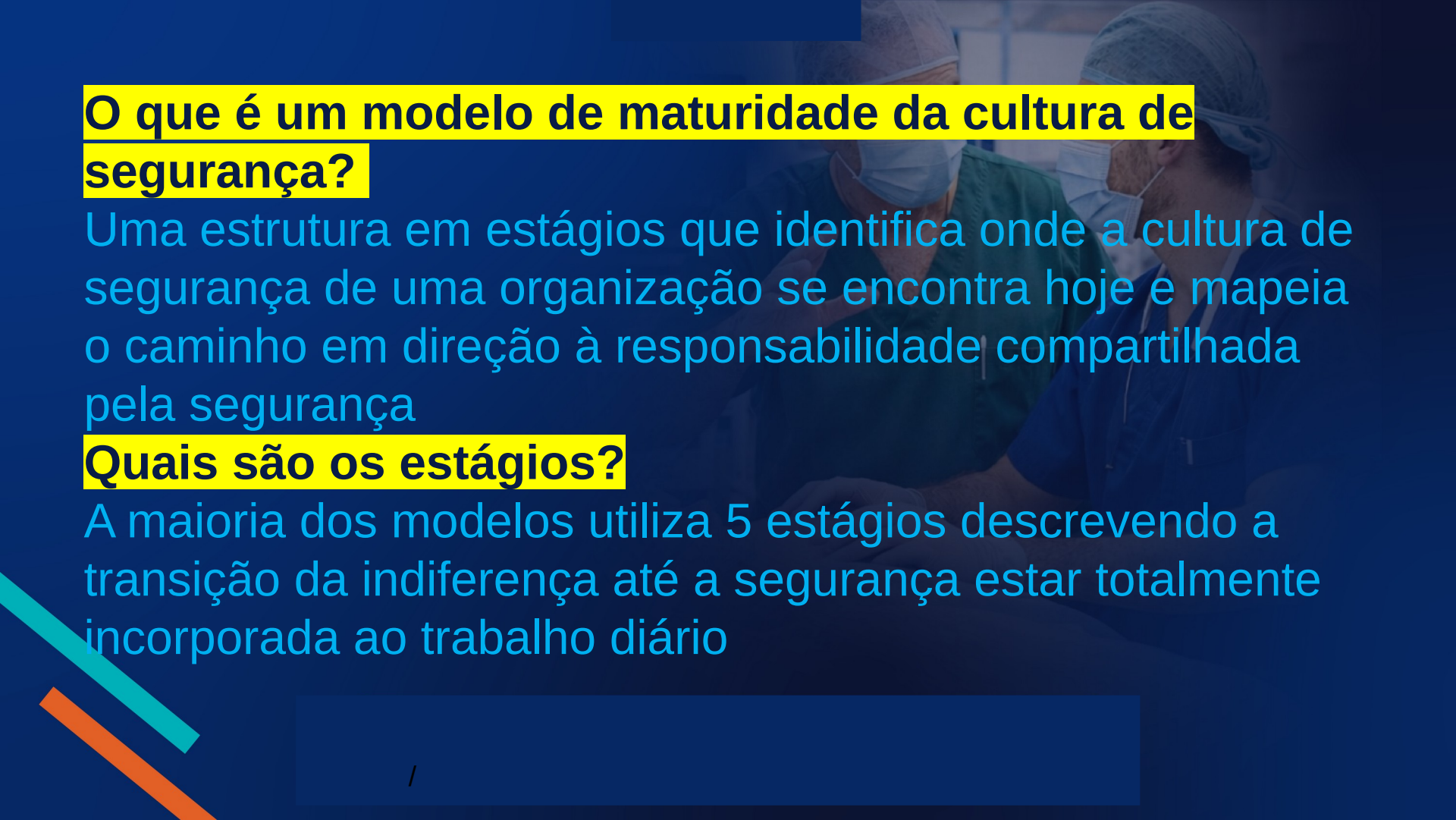
São os valores, crenças e padrões compartilhados pelos profissionais de saúde e demais trabalhadores de uma organização, que influenciam suas ações e condutas em relação à segurança

Reis CT, et al. doi: 10.1186/s12913-022-08890-7.

Cultura da Qualidade e Segurança



- Habilidades não técnicas
  - Comunicação - Consciência situacional - Resolução de conflitos
- Comportamento de time
- Empatia
- Ponderar sobre a autonomia médica
- “Disclosure”
- Suporte aos colegas



O que é um modelo de maturidade da cultura de segurança?

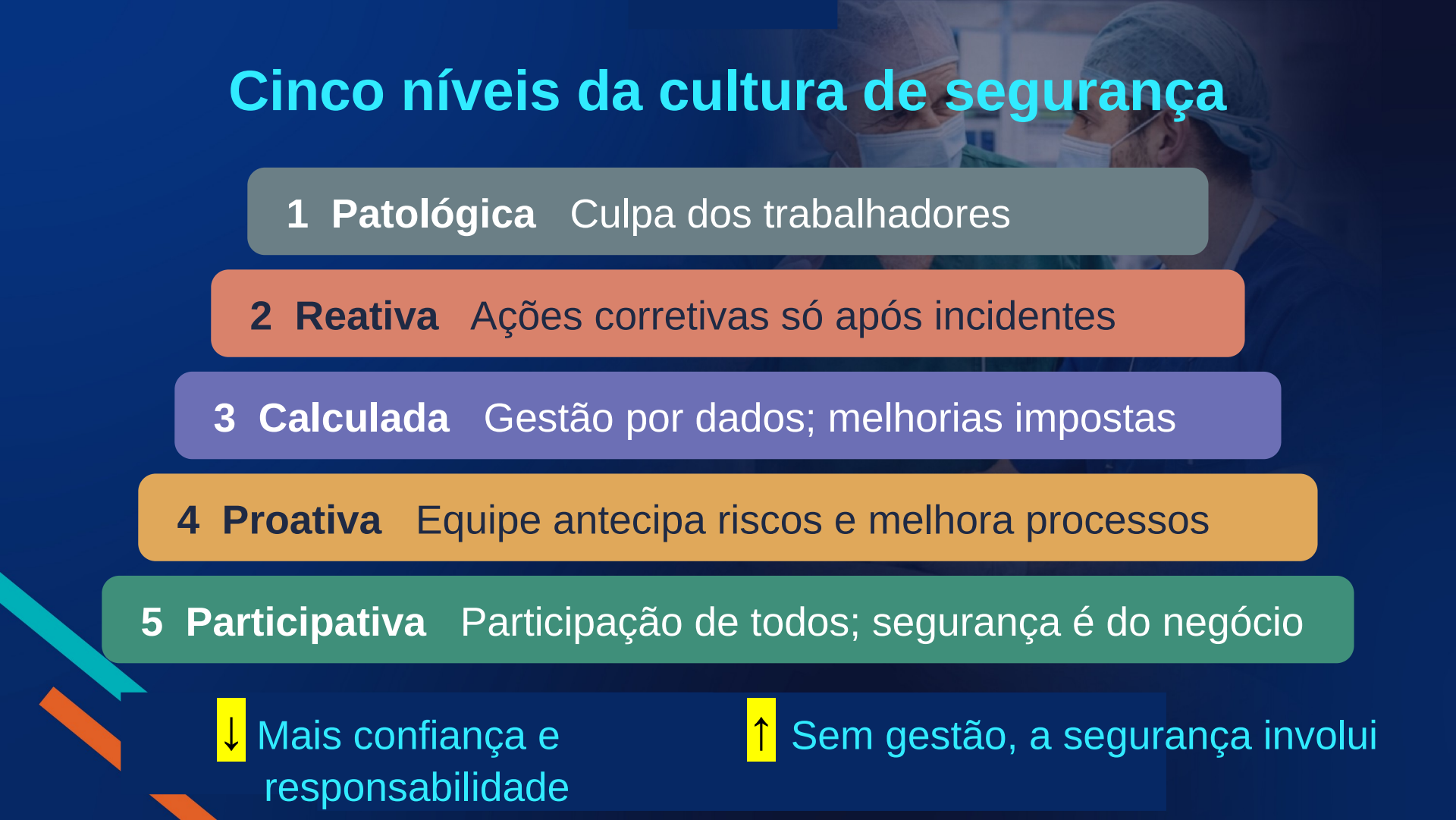
Uma estrutura em estágios que identifica onde a cultura de segurança de uma organização se encontra hoje e mapeia o caminho em direção à responsabilidade compartilhada pela segurança

Quais são os estágios?

A maioria dos modelos utiliza 5 estágios descrevendo a transição da indiferença até a segurança estar totalmente incorporada ao trabalho diário

/

Cinco níveis da cultura de segurança



1 **Patológica** Culpa dos trabalhadores

2 **Reativa** Ações corretivas só após incidentes

3 **Calculada** Gestão por dados; melhorias impostas

4 **Proativa** Equipe antecipa riscos e melhora processos

5 **Participativa** Participação de todos; segurança é do negócio

↓ Mais confiança e responsabilidade

↑ Sem gestão, a segurança involui

Cultura justa dentro da cultura de segurança

Cultura de segurança: valores e práticas compartilhados

Erro humano

Falha não intencional. Sem culpa: corrigir o sistema e apoiar a equipe.

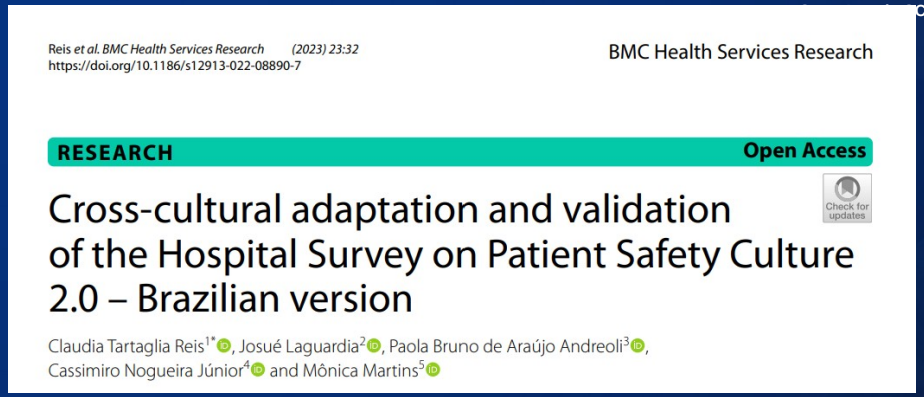
Comportamento de risco

Desvio de rotina que virou hábito. Orientar, reforçar e acompanhar.

Comportamento imprudente

Risco ignorado de forma consciente. Sanção proporcional.

Cultura justa: a resposta é proporcional ao comportamento, e não ao resultado.



Reis et al. BMC Health Services Research (2023) 23:32
https://doi.org/10.1186/s12913-022-08890-7

BMC Health Services Research

RESEARCH Open Access

Cross-cultural adaptation and validation of the Hospital Survey on Patient Safety Culture 2.0 – Brazilian version

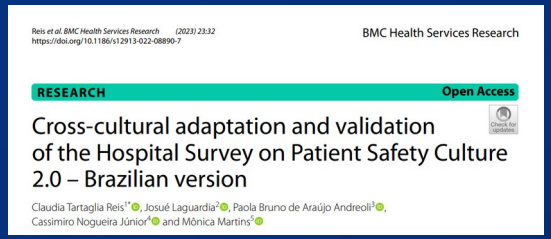
Claudia Tartaglia Reis[1*], Josué Laguardia[2], Paola Bruno de Araújo Andreoli[3], Cassimiro Nogueira Júnior[4] and Mônica Martins[5]

Como avaliar a Cultura de Segurança?

Instrumento para avaliação da cultura de segurança do paciente em hospitais

Estrutura: 40 itens, dos quais 32 se agrupam em 10 dimensões, com escala Likert de 5 pontos

Estudo: adaptação transcultural e validação para o português (Reis et al., *BMC Health Services Research*, 2023)



Reis et al. BMC Health Services Research (2023) 23:32
https://doi.org/10.1186/s12913-022-08890-7

BMC Health Services Research

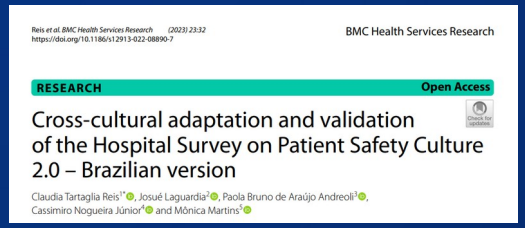
RESEARCH Open Access

Cross-cultural adaptation and validation of the Hospital Survey on Patient Safety Culture 2.0 – Brazilian version

Claudia Tartaglia Reis[1*], Josué Laguardia[2], Paola Bruno de Araújo Andreoli[3], Cassimiro Nogueira Júnior[4] and Mônica Martins[5]

O que mede: a percepção dos profissionais sobre a cultura de segurança do paciente na sua unidade de trabalho, isto é, valores, crenças e práticas compartilhadas que influenciam a segurança do cuidado.

Dimensões principais: trabalho em equipe, dimensionamento e ritmo de trabalho, aprendizado organizacional, resposta ao erro, apoio da liderança, comunicação sobre erros, abertura para comunicação, notificação de eventos, apoio da gestão hospitalar e passagens de plantão.



Reis et al. BMC Health Services Research (2023) 23:32
https://doi.org/10.1186/s12913-022-08890-7

BMC Health Services Research

RESEARCH Open Access

Cross-cultural adaptation and validation of the Hospital Survey on Patient Safety Culture 2.0 – Brazilian version

Claudia Tartaglia Reis[1*], Josué Laguardia[2], Paola Bruno de Araújo Andreoli[3], Cassimiro Nogueira Júnior[4] and Mônica Martins[5]

Pra que serve o HSPSC

Diagnóstico: identificar pontos fortes e fracos da cultura de segurança em uma unidade ou hospital, orientando investimentos em melhoria.

Monitoramento: acompanhar mudanças ao longo do tempo, por exemplo após a implantação de um protocolo ou de um programa de segurança.

Comparação: comparar resultados entre unidades, categorias profissionais ou com outras instituições, quando os dados são comparáveis.

Contexto no Brasil: a Política Nacional de Segurança do Paciente incentiva a medição da cultura de segurança como primeiro passo para a melhoria.

O modelo atual de intervenção é limitado?

- A Segurança-I, focada em prever e prevenir falhas, tem limites. As situações não pensadas, não entram nos planos de prevenção

- As mais drásticas melhorias de segurança demonstradas até o momento foram aquelas centradas num problema clínico bem definido e com uma escala de tempo relativamente curta

Paradoxo de barreiras



Piper Alfa
Mar do norte

167 mortos

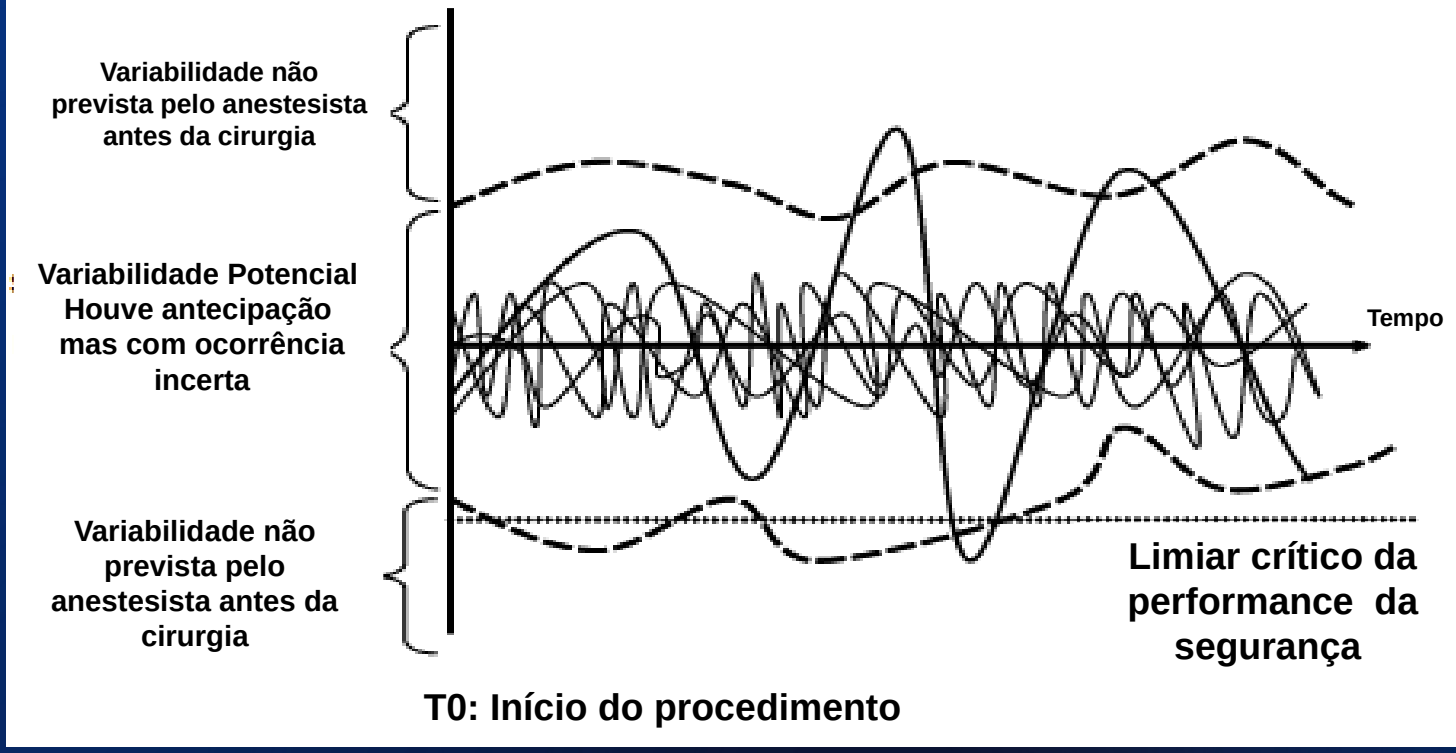
Trabalhadores se dirigiram-se para as áreas de refúgio de segurança que não protegeu adequadamente contra a fumaça.
Os trabalhadores aguardaram uma evacuação que não ocorreu a tempo

Quando a proteção gera o incidente

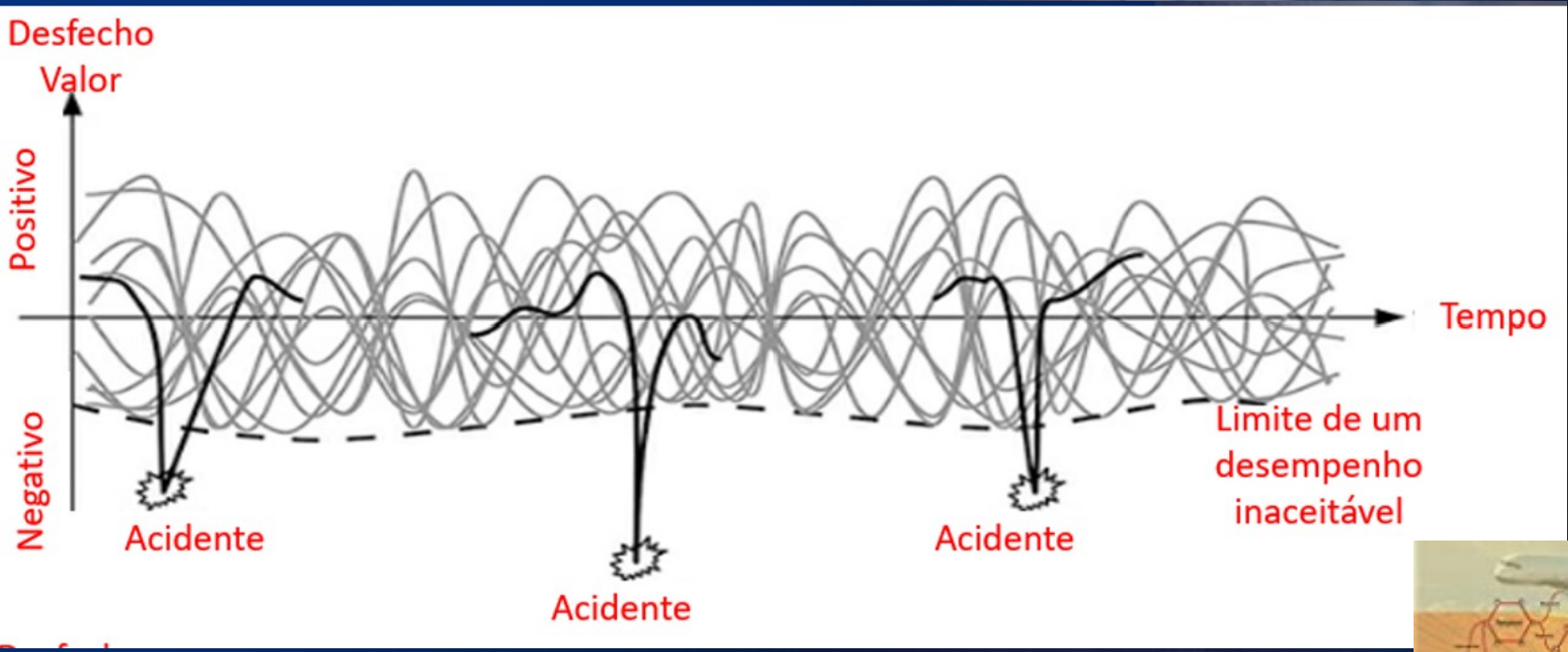


Origem em teste de sistema elétrico redundante para não interromper o sistema de resfriamento

Variabilidade da Performance

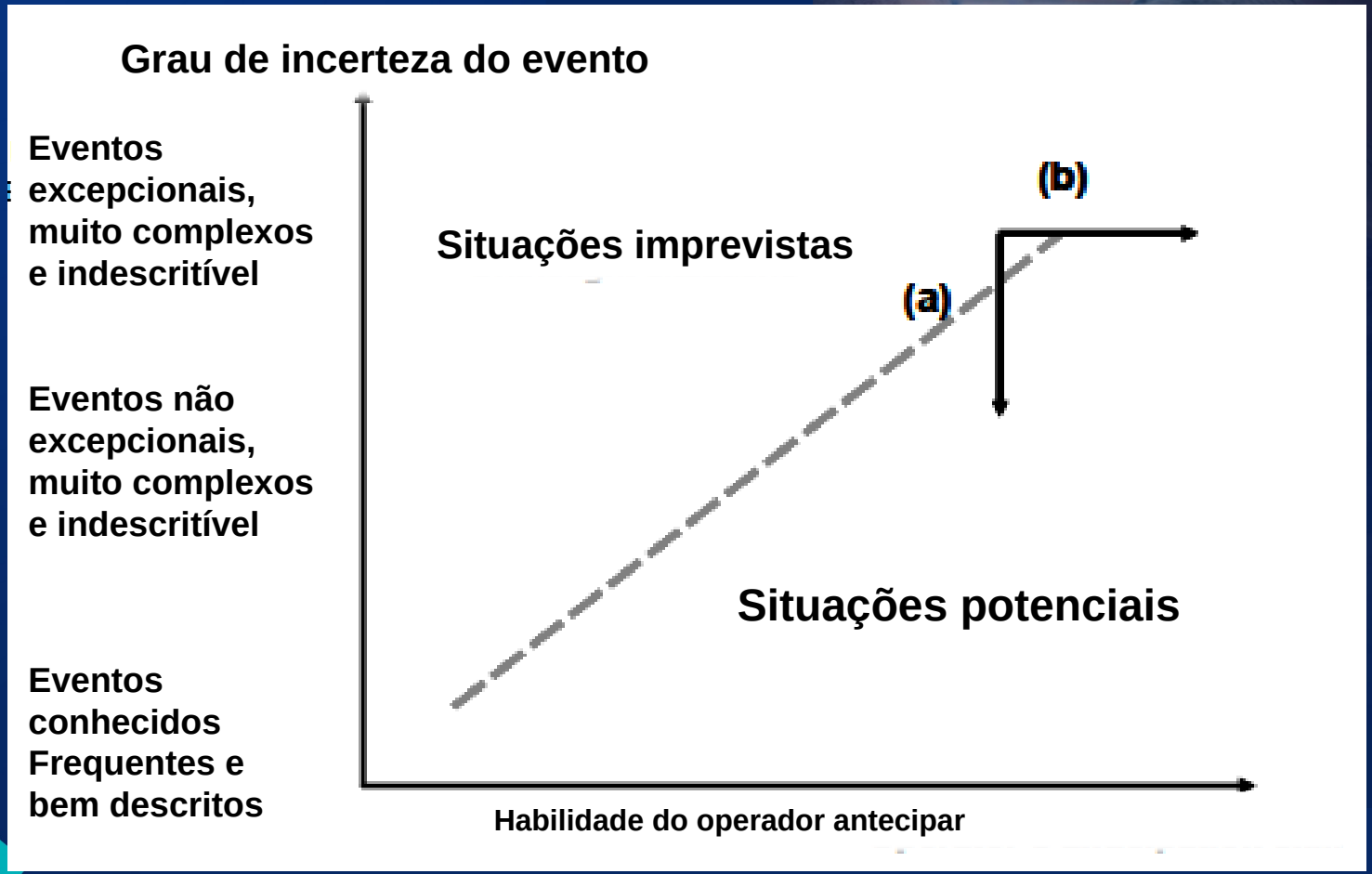


Cuvelier L, Falzon P. - 2015



Hollnagel E, et al. 2015





Cuvelier L, Falzon P. - 2015

De Segurança-I para Segurança-II

Segurança-I: minimizar o que dá errado

- Foco nas falhas e nos eventos adversos
- Pessoas vistas como fonte de variabilidade
- Investigação para achar causas e corrigi-las
- Compara o trabalho com o prescrito

Segurança-II: maximizar o que dá certo

- Foco no que funciona na maioria das vezes
- Variabilidade vista como capacidade de adaptação
- Entende como o trabalho dá certo para explicar as falhas
- Parte do trabalho real, como é feito

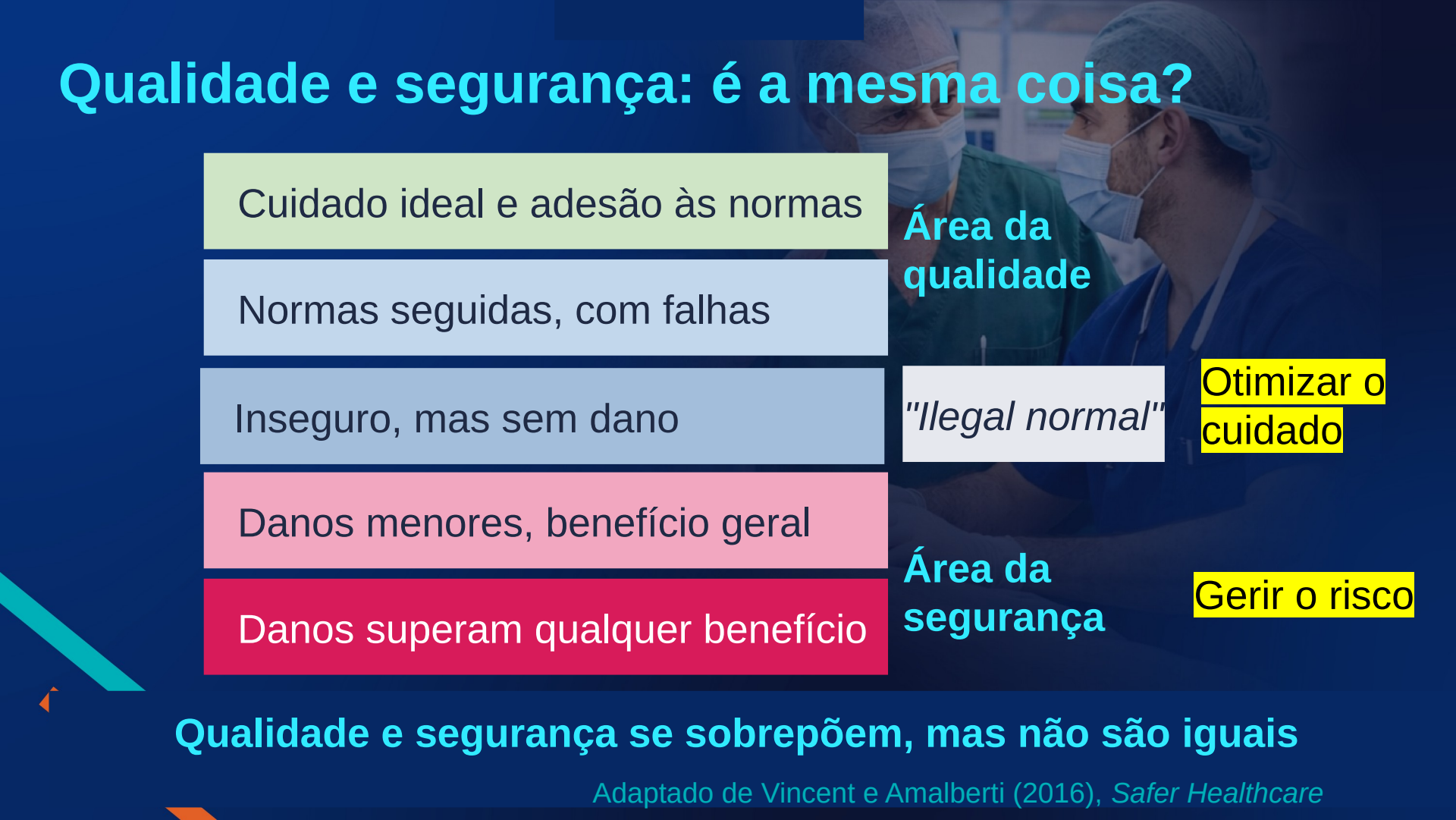
Segurança-II complementa, e não substitui, a Segurança-I.

MÓDULO 4

Síntese & Debates

- Afinal, qualidade e segurança são diferentes na saúde?
- Fenômeno da Segunda Vítima
- Prática de Disclosure ao paciente

Qualidade e segurança: é a mesma coisa?



Cuidado ideal e adesão às normas

Normas seguidas, com falhas

Área da qualidade

Inseguro, mas sem dano

"Ilegal normal"

Otimizar o cuidado

Danos menores, benefício geral

Danos superam qualquer benefício

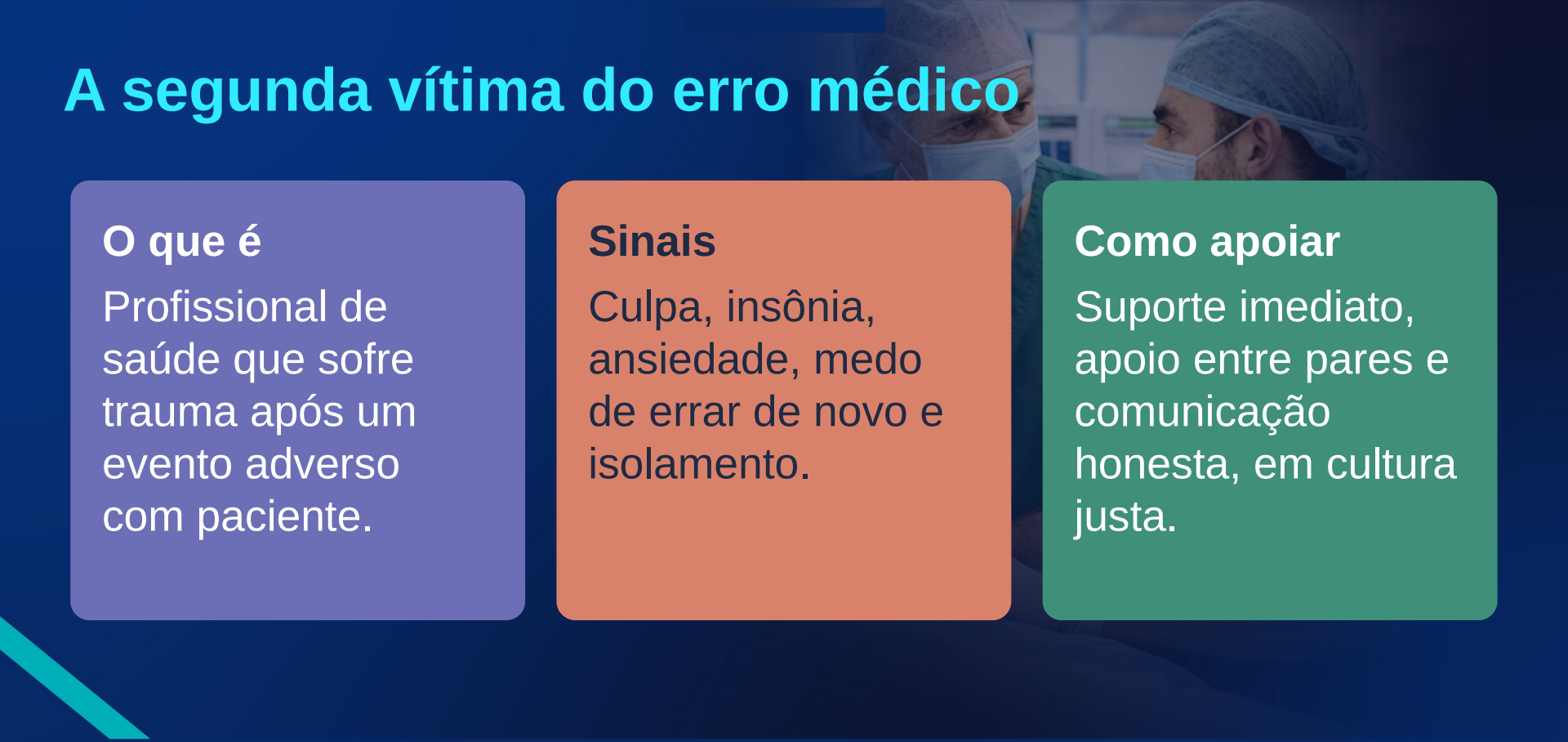
Área da segurança

Gerir o risco

Qualidade e segurança se sobrepõem, mas não são iguais

Adaptado de Vincent e Amalberti (2016), *Safer Healthcare*

A segunda vítima do erro médico



O que é

Profissional de saúde que sofre trauma após um evento adverso com paciente.

Sinais

Culpa, insônia, ansiedade, medo de errar de novo e isolamento.

Como apoiar

Suporte imediato, apoio entre pares e comunicação honesta, em cultura justa.

Cuidar de quem errou também é segurança do paciente

Disclosure: comunicação do evento adverso

Comunicação honesta ao paciente e à família sobre o que aconteceu e o que será feito

1 Rápido	2 Claro	3 Empático	4 Seguir
Comunicar logo após o evento, sem atrasos.	Explicar o que houve, sem especular sobre causas.	Reconhecer o dano e pedir desculpas.	Dizer o que será feito e manter o contato.

Base ética: o médico deve informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico e os riscos.

A segurança é um alvo em movimento...







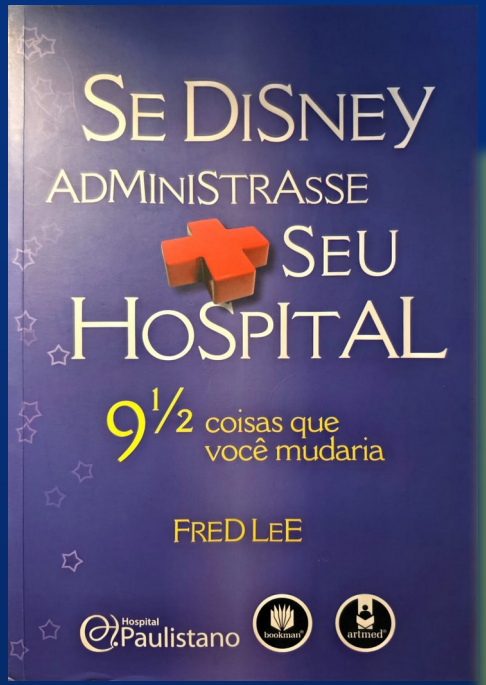


A segurança é um alvo em movimento...



A segurança é um alvo em movimento...





Quando você estiver diante de duas demandas conflitantes, entender essas prioridades o ajudará a discernir exatamente qual interesse tem precedência".

Em seguida, ele apresentou um cartaz com essas quatro prioridades, nesta ordem:

1. SEGURANÇA
2. CORTESIA
3. APRESENTAÇÃO (SHOW)
4. EFICIÊNCIA

Programa de Aprimoramento em Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura

OBRIGADO

www.cuidarseguro.com.br

Sociedade Brasileira de Anestesiologia

Instituto SBA de Simulação e Certificação

OPAS

SUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO DO BRASIL

DO LADO DO POVO BRASILEIRO